



# Bunga Rampai

# **PENGUATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME**

## TENAGA KESEHATAN DI ERA MODERN

Sri Wulan • Deasy Elvianita • Nur Miladiyah Rahmah  
Wiwin Winarti • Siska Mayang Sari • Intan Rina Susilawati

Editor : Tita Rohita

# **BUNGA RAMPAI**

## **PENGUATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME TENAGA KESEHATAN DI ERA MODERN**

### **Penulis:**

Bd. Sri Wulan, SST., M.Tr.Keb.

Deasy Elvianita, S.ST., M.Keb.

Dr. Nur Miladiyah Rahmah, S.Kp., M.Kep.

Dra. Wiwin Winarti, S.S., M.I.Kom.

Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep.

Intan Rina Susilawati, S.ST., Bdn., M.Keb.

### **Editor:**

Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep.



# **BUNGA RAMPAI PENGUATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME TENAGA KESEHATAN DI ERA MODERN**

## **Penulis:**

Bd. Sri Wulan, SST., M.Tr.Keb.  
Deasy Elvianita, S.ST., M.Keb.  
Dr. Nur Miladiyah Rahmah, S.Kp., M.Kep.  
Dra. Wiwin Winarti, S.S., M.I.Kom.  
Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep.  
Intan Rina Susilawati, S.ST., Bdn., M.Keb.

**Editor:** Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep.

**Desain Sampul:** Ivan Zumarano

**Penata Letak:** Muhamad Rizki Alamsyah

**ISBN:** 978-634-7556-67-7

**Cetakan Pertama :** Februari, 2026

Hak Cipta 2026

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Copyright © 2025**

**Penerbit Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : [optimaluntuknegeri.com](http://optimaluntuknegeri.com)

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



## **PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



# PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga bookchapter berjudul "Bunga Rampai: Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan di Era Modern" dapat disusun dan diselesaikan. Bookchapter ini hadir sebagai respon atas dinamika perkembangan dunia kesehatan yang semakin cepat, kompleks, serta menuntut tenaga kesehatan untuk terus beradaptasi dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta masyarakat.

Era modern ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, digitalisasi layanan, meningkatnya akses informasi publik, serta perubahan pola hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien. Pasien kini tidak lagi diposisikan sebagai objek pelayanan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ini menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya unggul dalam keterampilan klinis, namun juga memiliki kompetensi profesional yang mencakup komunikasi efektif, etika praktik, keselamatan pasien, kemampuan kolaborasi interprofesional, pemahaman hukum kesehatan, serta sensitivitas sosial-budaya dalam pelayanan.

Bookchapter ini disusun untuk memberikan pemahaman dan referensi praktis terkait konsep, tantangan, dan strategi penguatan kompetensi serta profesionalisme tenaga kesehatan. Materi di dalamnya disajikan melalui beragam perspektif dan konteks layanan kesehatan, sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai pentingnya kompetensi yang komprehensif. Bunga rampai ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa kesehatan, tenaga kesehatan pemula, praktisi, pendidik, maupun pengambil kebijakan sebagai sumber belajar dan bahan refleksi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Penulis menyadari bahwa penguatan profesionalisme tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu, karya ini juga mendorong pentingnya pelatihan berkelanjutan, pembinaan mutu, pengembangan budaya kerja yang etis dan aman, serta pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab untuk mendukung layanan kesehatan yang humanis dan berpusat pada pasien serta keluarga.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi pemikiran, dan masukan dalam

penyusunan bookchapter ini. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga bookchapter ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi inspirasi bagi tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, serta berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Februari, 2026

**Penulis**



# DAFTAR ISI



|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>PRAKATA.....</b>    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b> | <b>v</b>   |

## **CHAPTER 1 KONSEP KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME TENAGA**

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>KESEHATAN .....</b>                                                                           | <b>1</b> |
| <b>Bd. Sri Wulan, SST., M.Tr.Keb.....</b>                                                        | <b>1</b> |
| A. Pendahuluan / Prolog.....                                                                     | 1        |
| B. Pengertian Kompetensi dan profesional Tenaga Kesehatan.....                                   | 2        |
| C. Dimensi dan Komponen Kompetensi Tenaga Kesehatan .....                                        | 4        |
| D. Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan .....                                                     | 6        |
| E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Tenaga Kesehatan.....                              | 7        |
| F. Prinsip dan Nilai-nilai Profesionalisme Tenaga Kesehatan .....                                | 8        |
| G. Hubungan Kompetensi dan Profesionalisme dalam Praktik Pelayanan<br>Kesehatan.....             | 10       |
| H. Penerapan Kompetensi dan Profesionalisme dalam Pelayanan<br>Kesehatan.....                    | 12       |
| I. Tantangan Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga<br>Kesehatan di Era Modern ..... | 13       |
| J. Upaya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga<br>Kesehatan.....                     | 15       |
| K. Simpulan.....                                                                                 | 17       |
| L. Referensi.....                                                                                | 18       |
| M. Glosarium .....                                                                               | 20       |

## **CHAPTER 2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEBIDANAN.....21**

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Deasy Elvianita, S.ST., M.Keb .....</b>                           | <b>21</b> |
| A. Pendahuluan / Prolog.....                                         | 21        |
| B. Konsep Kompetensi Tenaga Kebidanan .....                          | 22        |
| C. Standar Kompetensi Bidan.....                                     | 23        |
| D. Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kompetensi Bidan .....      | 24        |
| E. Kerangka Teori Pengembangan Kompetensi Tenaga Kebidanan .....     | 24        |
| F. Strategi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kebidanan.....            | 25        |
| G. Peran Organisasi Profesi Dalam Pengembangan Kompetensi Bidan..... | 25        |
| H. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Bidan.....         | 26        |
| I. Indikator Keberhasilan Pengembangan Kompetensi Bidan .....        | 27        |
| J. Dampak Pengembangan Kompetensi Terhadap Kualitas Pelayanan.....   | 28        |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| K. Pengembangan Kompetensi Dalam Perspektif Akreditasi..... | 29 |
| L. Tantangan dan Strategi.....                              | 29 |
| M. Simpulan.....                                            | 29 |
| N. Referensi.....                                           | 30 |
| O. Glosarium .....                                          | 31 |

### **CHAPTER 3 PENGUATAN KOMPETENSI PERAWAT DALAM PRAKTIK**

#### **PELAYANAN.....33**

#### **Dr. Nur Miladiyah Rahmah, S.Kp., M.Kep. ....33**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan / Prolog.....                                  | 33 |
| B. Penguatan Kompetensi Perawat Dalam Praktik Pelayanan ..... | 34 |
| C. Simpulan.....                                              | 45 |
| D. Referensi .....                                            | 46 |
| E. Glosarium .....                                            | 47 |

### **CHAPTER 4 PENGUATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME**

#### **TENAGA KESEHATAN DI ERA MODERN KOMPETENSI TENAGA**

#### **KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KESEHATAN .....49**

#### **Dra. Wiwin Winarti, S.S., M.I.Kom. ....49**

|                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan / Prolog.....                                                                                                                                                   | 49 |
| B. Kompetensi Tenaga Kesehatan dalam Praktik Informed Consent .....                                                                                                            | 51 |
| C. Refleksi Empiris dari Praktik Informed Consent Tenaga Kesehatan .....                                                                                                       | 52 |
| D. Hambatan dalam Implementasi Informed Consent pada Program<br>Kesehatan.....                                                                                                 | 53 |
| E. Implikasi bagi Penguatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Masyarakat .....                                                                                                       | 55 |
| F. Komunikasi Tenaga Kesehatan – Pasien. Pendekatan Teoretis:<br>Uncertainty Reduction Theory, Social Penetration Theory, dan<br>Temperamen Pasien dalam Informed Consent..... | 58 |
| G. Simpulan.....                                                                                                                                                               | 61 |
| H. Referensi .....                                                                                                                                                             | 61 |
| I. Glosarium .....                                                                                                                                                             | 62 |

### **CHAPTER 5 PERAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **BERKELANJUTAN/ CONTINUOUS PROFESSIONAL**

#### **DEVELOPMENT(CPD).....65**

#### **Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep. ....65**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan / Prolog.....                                            | 65 |
| B. Konsep dasar CPD dan pentingnya .....                                | 67 |
| C. Peran pelatihan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan ..... | 68 |
| D. Pengembangan Berkelanjutan: Kunci untuk Profesionalisme.....         | 70 |

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E. Tantangan era modern terhadap pelatihan sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan..... | 72 |
| F. Simpulan.....                                                                                      | 75 |
| G. Referensi .....                                                                                    | 77 |
| H. Glosarium .....                                                                                    | 78 |

## **CHAPTER 6 TANTANGAN DAN STRATEGI MENINGKATKAN PROFESIONALISME TENAGA KESEHATAN .....81**

### **Intan Rina Susilawati, S.ST., Bdn., M.Keb.....81**

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pendahuluan / Prolog.....                                                                      | 81 |
| B. Konsep Profesionalisme Tenaga Kesehatan .....                                                  | 81 |
| C. Tantangan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Di Era Modern .....                                 | 82 |
| D. Strategi Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Di Indonesia .....                      | 83 |
| E. Peran Kepemimpinan dan Kebijakan dalam Penguatan Profesionalisme<br>86                         |    |
| F. Implikasi Profesionalisme Terhadap Mutu Dan Keselamatan Pasien.....                            | 86 |
| G. Studi Kasus Penguatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Di Indonesia .....                      | 87 |
| H. Penguatan Profesionalisme Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Kunci.....                            | 87 |
| I. Kerangka Konseptual Penguatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan.....                            | 88 |
| J. Tantangan Dan Peluang Profesionalisme Tenaga Kesehatan Di Masa Depan .....                     | 88 |
| K. Profesionalisme Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Interprofesional Dan Kolaborasi Layanan..... | 88 |
| L. Simpulan.....                                                                                  | 89 |
| M. Referensi .....                                                                                | 90 |
| N. Glosarium .....                                                                                | 91 |

## **PROFIL PENULIS .....93**





# CHAPTER 1

## KONSEP KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME TENAGA KESEHATAN

Bd. Sri Wulan, SST., M.Tr.Keb.

### A. Pendahuluan / Prolog

Tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta masyarakat. Kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kesehatan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab profesional secara optimal sesuai dengan standar yang berlaku. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa kinerja sistem kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional, karena hal tersebut berkontribusi langsung terhadap keselamatan pasien dan efektivitas layanan kesehatan (*World Health Organization*, 2022). Oleh karena itu, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan menjadi komponen utama dalam penguatan sistem pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.

Kompetensi tenaga kesehatan merujuk pada kemampuan holistik yang mencakup penguasaan pengetahuan ilmiah, keterampilan praktik klinis, kemampuan komunikasi interpersonal, serta sikap profesional yang selaras dengan standar praktik dan etika profesi. Kompetensi tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis, tetapi juga meliputi aspek non-teknis seperti kemampuan pengambilan keputusan klinis, komunikasi efektif, dan penerapan nilai-nilai moral dalam praktik pelayanan kesehatan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kompetensi profesional kebidanan memiliki hubungan yang signifikan dengan keberanian moral, efektivitas komunikasi, serta komitmen terhadap peningkatan mutu praktik klinis secara berkelanjutan, yang secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan (Ali & Khalifa, 2025).

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, tuntutan terhadap kompetensi tenaga kesehatan semakin kompleks. Tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan teknologi dan regulasi pelayanan kesehatan, serta mampu bekerja secara efektif dalam tim interprofesional. Selain itu, pendekatan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien menuntut tenaga kesehatan untuk

memahami latar belakang sosial, budaya, dan psikologis pasien agar pelayanan yang diberikan bersifat holistik dan bermakna. Dalam konteks kesehatan masyarakat, kompetensi tenaga kesehatan juga mencakup kemampuan komunikasi yang efektif, kolaborasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Di samping kompetensi, profesionalisme merupakan aspek fundamental yang menentukan mutu praktik tenaga kesehatan. Profesionalisme tercermin melalui sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang menunjukkan komitmen terhadap etika profesi, tanggung jawab moral, serta penghormatan terhadap martabat dan hak pasien. Tenaga kesehatan yang profesional senantiasa menempatkan kepentingan pasien sebagai prioritas utama, mematuhi kode etik profesi, serta berupaya meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Profesionalisme juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan dan memperkuat hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien (Alnasser, 2024).

Dalam perspektif pelayanan kesehatan modern, profesionalisme tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan dan standar etika, tetapi juga mencakup kemampuan tenaga kesehatan untuk bertindak secara otonom, bertanggung jawab, adaptif, dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan praktik profesional. Nilai-nilai humanistik seperti empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian integral dari profesionalisme tenaga kesehatan, terutama di tengah tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks akibat perubahan demografis, transisi epidemiologi, dan kemajuan teknologi kesehatan (*World Health Organization*, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Penguatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan menjadi strategi penting dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan guna menjawab tantangan pelayanan kesehatan masa kini dan masa depan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan

## **B. Pengertian Kompetensi dan profesional Tenaga Kesehatan**

---

Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa kompetensi tenaga kesehatan merupakan hasil integrasi antara pengetahuan ilmiah, keterampilan praktik, dan perilaku profesional yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien serta kebutuhan individu dan

masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi menjadi elemen fundamental dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan dan mendukung efektivitas serta keberlanjutan sistem kesehatan secara keseluruhan (WHO, 2022).

Dalam implementasinya, kompetensi tenaga kesehatan mencakup tiga domain utama, yaitu kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif. Kompetensi kognitif berkaitan dengan pemahaman tenaga kesehatan terhadap ilmu pengetahuan kesehatan, pedoman klinis, dan kebijakan pelayanan. Kompetensi psikomotor mencerminkan kemampuan teknis dan klinis dalam memberikan asuhan kesehatan secara tepat, aman, dan sesuai standar. Sementara itu, kompetensi afektif berhubungan dengan sikap dan nilai profesional, seperti empati, integritas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan turut memperluas cakupan kompetensi tenaga kesehatan. Kompetensi saat ini juga meliputi kemampuan komunikasi interpersonal yang efektif, kerja sama dalam tim interprofesional, pemanfaatan teknologi informasi kesehatan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sistem dan regulasi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kompetensi tenaga kesehatan bersifat dinamis dan memerlukan pengembangan berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan refleksi praktik profesional secara terus-menerus (Alnasser, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi tenaga kesehatan dapat disimpulkan sebagai kemampuan holistik yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, beretika, berorientasi pada pasien, serta responsif terhadap tantangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang.

Sedangkan, secara konseptual profesionalisme merupakan perwujudan dari kompetensi yang diimplementasikan secara berkelanjutan dalam praktik melalui perilaku etis, pengambilan keputusan klinis yang bertanggung jawab, serta kepatuhan terhadap standar profesi dan regulasi yang berlaku. Tenaga kesehatan yang profesional mampu menjadikan keselamatan dan kesejahteraan pasien sebagai prioritas utama, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan, empati, dan penghormatan terhadap hak serta martabat manusia. Penerapan profesionalisme yang konsisten terbukti berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, kepercayaan pasien, dan akuntabilitas sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan (WHO, 2022; Alnasser, 2024).

## C. Dimensi dan Komponen Kompetensi Tenaga Kesehatan

---

Kompetensi tenaga kesehatan dapat dipahami sebagai konsep multidimensional yang merepresentasikan kemampuan profesional secara komprehensif dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berlandaskan etika. Kompetensi tidak dimaknai sebagai kemampuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil integrasi berbagai dimensi dan komponen yang saling berinteraksi serta memperkuat satu sama lain dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari (Frank et al., 2023; Alnasser, 2024).

### 1. Dimensi Kompetensi Tenaga Kesehatan

Dimensi kompetensi tenaga kesehatan menggambarkan ranah kemampuan utama yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawab profesional secara optimal.

- a. Dimensi kognitif berkaitan dengan kapasitas intelektual tenaga kesehatan dalam memahami, menguasai, dan mengaplikasikan pengetahuan ilmiah di bidang kesehatan. Dimensi ini mencakup penguasaan konsep dasar kesehatan, ilmu biomedik, pedoman klinis, kebijakan kesehatan, serta prinsip praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*). Selain itu, kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis yang rasional merupakan bagian integral dari dimensi kognitif karena berpengaruh langsung terhadap ketepatan asuhan dan keselamatan pasien (Frenk et al., 2022; Shorey & Ng, 2023).
- b. Dimensi psikomotor berkaitan dengan kemampuan tenaga kesehatan dalam menerapkan keterampilan teknis dan klinis saat melaksanakan tindakan pelayanan kesehatan. Dimensi ini mencakup kecakapan melakukan prosedur klinis secara tepat dan aman, penggunaan alat kesehatan sesuai standar, serta penerapan standar operasional prosedur dalam praktik pelayanan. Penguasaan keterampilan psikomotor yang memadai terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keselamatan pasien dan efektivitas pelayanan kesehatan (Govaerts et al., 2021; Labrague et al., 2024).
- c. Dimensi afektif mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku profesional tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Dimensi ini meliputi empati, tanggung jawab, integritas, disiplin, komitmen terhadap etika profesi, serta penghormatan terhadap hak dan martabat pasien. Penguatan dimensi afektif berperan penting dalam membangun hubungan terapeutik yang positif serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Alnasser, 2024; Wei et al., 2022).

### 2. Komponen Kompetensi Tenaga Kesehatan

Selain dimensi utama, kompetensi tenaga kesehatan juga didukung oleh sejumlah komponen yang memperkuat penerapannya dalam praktik profesional.

- a. Komponen pengetahuan (*knowledge*) merupakan dasar ilmiah yang mencakup teori, konsep, dan informasi terkini di bidang kesehatan. Penguasaan pengetahuan yang baik memungkinkan tenaga kesehatan mengambil keputusan klinis secara tepat, rasional, dan berbasis bukti ilmiah (Frank et al., 2023).
- b. Komponen keterampilan (*skills*) meliputi keterampilan teknis, klinis, dan prosedural yang dibutuhkan dalam pemberian asuhan kesehatan. Selain keterampilan klinis, komponen ini juga mencakup kemampuan komunikasi, edukasi kesehatan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan guna meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan (Labrague et al., 2024).
- c. Komponen sikap dan nilai profesional (*attitude and values*) berkaitan dengan etika, moral, dan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan. Komponen ini mencerminkan komitmen terhadap keselamatan pasien, mutu pelayanan, serta kepatuhan terhadap standar dan kode etik profesi (Wei et al., 2022).
- d. Komponen komunikasi dan interpersonal mencakup kemampuan tenaga kesehatan dalam berkomunikasi secara efektif, empatik, dan etis dengan pasien, keluarga, maupun anggota tim kesehatan. Komunikasi yang efektif terbukti berkontribusi pada peningkatan kepuasan pasien, penguatan kerja tim, serta penurunan risiko kesalahan dalam pelayanan kesehatan (Ong et al., 2020).
- e. Komponen kolaborasi interprofesional menunjukkan kemampuan tenaga kesehatan untuk bekerja sama secara efektif dengan berbagai profesi dalam tim multidisipliner. Kolaborasi yang baik mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pasien (Reeves et al., 2021).
- f. Komponen pengembangan profesional berkelanjutan mencerminkan kemampuan tenaga kesehatan untuk melakukan refleksi diri, pembelajaran sepanjang hayat, serta mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pengembangan ini penting untuk menjaga relevansi kompetensi tenaga kesehatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan (Davis et al., 2021).

### **3. Keterkaitan Dimensi dan Komponen Kompetensi**

Dimensi dan komponen kompetensi tenaga kesehatan saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Dimensi kompetensi merepresentasikan ranah kemampuan utama, sedangkan komponen kompetensi menjabarkan unsur-unsur spesifik yang mendukung penerapan kompetensi dalam praktik pelayanan. Penguatan seluruh dimensi dan komponen kompetensi

tersebut merupakan kunci dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, menjamin keselamatan pasien, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan (Frank et al., 2023; Labrague et al., 2024).

#### **D. Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan**

---

Standar kompetensi tenaga kesehatan merupakan seperangkat kriteria yang disusun secara terstruktur untuk menjamin bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki tingkat kemampuan minimal yang diperlukan dalam menjalankan praktik profesional secara aman, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip etika. Standar ini berperan sebagai rujukan utama, baik pada tingkat nasional maupun internasional, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, proses sertifikasi dan registrasi, serta penilaian kinerja tenaga kesehatan di berbagai setting pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2023; *World Health Organization* [WHO], 2022).

Secara konseptual, standar kompetensi merepresentasikan integrasi kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai profesional yang wajib dimiliki serta diwujudkan oleh tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan sehari-hari. Standar kompetensi tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan teknis semata, tetapi juga menekankan pentingnya keselamatan pasien, komunikasi yang efektif, penerapan etika profesi, serta kemampuan berkolaborasi secara interprofesional sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien (Frank et al., 2023; Reeves et al., 2021).

Di Indonesia, perumusan dan penetapan standar kompetensi tenaga kesehatan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan melibatkan organisasi profesi, institusi pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Standar kompetensi tersebut diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksana yang mengatur masing-masing jenis tenaga kesehatan. Standar ini menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan, pelaksanaan uji kompetensi nasional, serta penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai syarat legal praktik tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Secara umum, standar kompetensi tenaga kesehatan mencakup beberapa domain utama, antara lain kompetensi profesional, kompetensi klinis atau teknis, kompetensi komunikasi dan interpersonal, kompetensi etika dan hukum kesehatan, serta kompetensi pengembangan profesional berkelanjutan. Kompetensi profesional menitikberatkan pada tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan

terhadap kode etik profesi, sedangkan kompetensi klinis berfokus pada kemampuan memberikan asuhan sesuai standar praktik dan pedoman berbasis bukti. Kompetensi komunikasi dan kolaborasi mendukung efektivitas kerja tim dan keselamatan pasien, sementara kompetensi pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan tenaga kesehatan untuk terus menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompleksitas pelayanan kesehatan (WHO, 2022; Davis et al., 2021).

Implementasi standar kompetensi tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Keberadaan standar yang jelas, terukur, dan terintegrasi memungkinkan institusi pelayanan kesehatan menjaga konsistensi kualitas asuhan, menekan risiko terjadinya kesalahan pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Selain itu, standar kompetensi juga berfungsi sebagai dasar dalam penilaian kinerja, perencanaan pengembangan karier, dan peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan secara berkelanjutan (Frank et al., 2023; Labrague et al., 2024).

## **E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Tenaga Kesehatan**

---

Kompetensi tenaga kesehatan tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari individu, organisasi, dan lingkungan kerja. Faktor-faktor tersebut dapat memperkuat atau menghambat kemampuan tenaga kesehatan dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang diperlukan dalam praktik pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman (Erfani et al., 2025; Haruta et al., 2023).

### **1. Pendidikan dan Pengalaman Profesional**

Tingkat pendidikan formal dan pengalaman kerja merupakan faktor penting dalam pembentukan kompetensi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dengan pendidikan yang lebih tinggi dan masa kerja yang lebih lama cenderung memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap praktik klinis dan pengambilan keputusan, serta lebih cepat beradaptasi terhadap situasi kompleks di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini terlihat dalam kajian yang menunjukkan hubungan antara pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi profesional tenaga kesehatan (Erfani et al., 2025).

### **2. Pelatihan dan Pengembangan Profesional**

Salah satu faktor terpenting yang memengaruhi kompetensi adalah kegiatan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Pelatihan yang terstruktur dalam keterampilan teknis, komunikasi, pengelolaan stres, dan literasi kesehatan membantu tenaga kesehatan memperbarui keterampilan dan kemampuan



klinisnya. Dukungan pelatihan berkelanjutan menjadi faktor utama yang mendukung perkembangan kompetensi di berbagai jenis layanan kesehatan (Toto, 2025).

### **3. Dukungan Organisasi dan Lingkungan Kerja**

Lingkungan kerja yang mendukung secara organisasi dapat meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Komunikasi yang baik, kepemimpinan yang efektif, hubungan kerja yang positif, serta budaya kerja yang kondusif menjadi faktor internal yang secara signifikan memengaruhi perkembangan kemampuan profesional. Organisasi yang secara aktif memberikan umpan balik, penghargaan, dan dukungan struktural cenderung memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi yang lebih tinggi (Haruta et al., 2023; Erfani et al., 2025).

### **4. Teknologi dan Akses Informasi**

Perkembangan teknologi kesehatan, termasuk kompetensi digital kesehatan, juga menjadi faktor yang kian penting. Tenaga kesehatan yang memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi kesehatan menunjukkan kompetensi yang lebih baik dalam pelayanan modern, khususnya dalam pelayanan yang melibatkan teknologi digital seperti telemedicine dan catatan kesehatan elektronik (Erfani et al., 2025).

### **5. Faktor Individu dan Sosial**

Faktor personal seperti motivasi kerja, kepercayaan diri, sikap profesional, serta kemampuan berkomunikasi interpersonal turut memengaruhi kompetensi tenaga kesehatan. Motivasi internal yang tinggi mendorong tenaga kesehatan untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja, sedangkan dukungan sosial dari rekan kerja dan masyarakat memperkuat rasa tanggung jawab dan komitmen profesional (Haruta et al., 2023; Toto, 2025).

## **F. Prinsip dan Nilai-nilai Profesionalisme Tenaga Kesehatan**

---

Profesionalisme tenaga kesehatan berlandaskan pada seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai profesional yang berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, serta mengambil keputusan selama praktik pelayanan kesehatan. Nilai-nilai tersebut tidak semata-mata merepresentasikan kecakapan teknis, tetapi juga mencerminkan orientasi etis, tanggung jawab moral, serta kualitas hubungan interpersonal yang mendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan pasien (Pakkanen et al., 2023).

### **1. Prinsip Utama Profesionalisme Tenaga Kesehatan**

Profesionalisme dalam pelayanan kesehatan dibangun di atas sejumlah prinsip fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan praktik profesional, antara lain:

a. Komitmen terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien

Tenaga kesehatan dituntut untuk senantiasa mengutamakan keselamatan, kebutuhan, dan hak pasien dalam setiap proses pengambilan keputusan pelayanan. Prinsip ini berkaitan erat dengan penghormatan terhadap martabat manusia, otonomi pasien, serta upaya menjamin kesejahteraan pasien dalam seluruh rangkaian pelayanan klinis dan hubungan terapeutik.

b. Kepatuhan terhadap etika profesi dan kode etik

Profesionalisme mengharuskan tenaga kesehatan menjalankan praktik sesuai dengan kode etik profesi dan prinsip-prinsip etika dasar, seperti beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak menimbulkan bahaya), justice (keadilan), dan autonomy (penghormatan terhadap otonomi pasien). Kode etik tersebut menjadi landasan perilaku profesional yang etis, adil, dan bertanggung jawab dalam pelayanan kesehatan.

c. Integritas dan akuntabilitas

Integritas profesional tercermin dari keselarasan antara nilai, sikap, dan tindakan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, tenaga kesehatan dituntut memiliki akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan klinis, termasuk kesiapan menghadapi konsekuensi atas kesalahan atau dilema etika yang muncul dalam praktik.

d. Komunikasi dan hubungan interpersonal yang etis

Kemampuan berkomunikasi secara efektif, jelas, dan empatik dengan pasien, keluarga, serta sesama tenaga kesehatan merupakan aspek penting profesionalisme. Komunikasi yang baik mendukung kolaborasi antarprofesi, pengambilan keputusan bersama, serta pembentukan hubungan terapeutik yang dilandasi saling menghormati dan kepercayaan

e. Pembelajaran berkelanjutan dan refleksi diri

Profesionalisme juga tercermin melalui komitmen tenaga kesehatan terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan refleksi kritis atas praktik yang dijalankan. Upaya ini penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran nilai profesional dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompleksitas pelayanan kesehatan.

## **2. Nilai-Nilai Inti Profesionalisme**

Nilai-nilai inti yang menopang prinsip profesionalisme tenaga kesehatan meliputi:

- a. Kemanusiaan (*humanity*), yaitu penghormatan terhadap martabat setiap pasien tanpa diskriminasi, disertai pelayanan yang berlandaskan empati dan kepedulian.
- b. Keadilan dan kesetaraan (*justice*), yakni perlakuan yang adil terhadap seluruh pasien serta jaminan akses pelayanan kesehatan yang setara tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.
- c. Integritas (*integrity*), yang tercermin dari kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi dalam bersikap serta bertindak sesuai standar profesi.
- d. Tanggung jawab profesional (*professional responsibility*), berupa kesiapan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas sesuai kompetensi serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan berdasarkan kode etik profesi.
- e. Kolaborasi dan kerja tim (*collaboration*), yaitu nilai yang mendorong kerja sama lintas profesi dalam tim multidisipliner untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang holistik dan terintegrasi.

### **3. Peran Prinsip dan Nilai Profesionalisme dalam Praktik Pelayanan**

Penerapan prinsip dan nilai profesionalisme berperan penting dalam membimbing perilaku tenaga kesehatan, meminimalkan potensi konflik, serta meningkatkan keselamatan dan mutu pelayanan. Selain itu, profesionalisme yang kuat turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dengan menjunjung tinggi nilai etika dan profesional, tenaga kesehatan dapat menjaga kredibilitas profesinya, memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi, serta berkontribusi sebagai agen perubahan dalam pengembangan pelayanan kesehatan modern (Pakkanen et al., 2023).

## **G. Hubungan Kompetensi dan Profesionalisme dalam Praktik Pelayanan Kesehatan**

Kompetensi dan profesionalisme merupakan dua konsep inti yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik pelayanan kesehatan. Kompetensi merujuk pada kapasitas tenaga kesehatan dalam mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, keterampilan klinis, dan sikap profesional untuk memberikan asuhan secara efektif. Sementara itu, profesionalisme menggambarkan cara kompetensi tersebut diwujudkan dalam praktik melalui perilaku etis, tanggung jawab moral, serta orientasi pada keselamatan dan kepentingan pasien. Dengan demikian, kompetensi berfungsi sebagai dasar kemampuan teknis dan klinis, sedangkan profesionalisme memastikan bahwa kemampuan tersebut dijalankan selaras dengan nilai moral, etika profesi, dan standar pelayanan kesehatan (Frenk et al., 2022; Frank et al., 2023).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, penguasaan kompetensi tanpa diimbangi profesionalisme dapat menghasilkan tindakan yang benar secara teknis tetapi berpotensi mengabaikan aspek etika, empati, dan keselamatan pasien. Sebaliknya, sikap profesional yang tidak didukung kompetensi yang memadai dapat meningkatkan risiko kesalahan klinis dan menurunkan mutu asuhan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dituntut untuk tidak hanya unggul secara ilmiah dan teknis, tetapi juga menunjukkan profesionalisme dalam sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan klinis sehari-hari (Cruess et al., 2022; Frank et al., 2023).

Keterkaitan antara kompetensi dan profesionalisme tampak jelas dalam proses pengambilan keputusan klinis. Kompetensi memungkinkan tenaga kesehatan melakukan penilaian klinis yang akurat berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sedangkan profesionalisme mengarahkan keputusan tersebut agar tetap menjunjung tinggi prinsip keselamatan pasien, keadilan, serta penghormatan terhadap otonomi pasien. Integrasi kedua aspek ini berperan penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berpusat pada pasien (*World Health Organization*, 2022).

Selain itu, kompetensi dan profesionalisme juga menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kerja tim interprofesional. Kompetensi memastikan setiap tenaga kesehatan mampu menjalankan peran sesuai lingkup praktiknya, sementara profesionalisme mendorong terciptanya komunikasi yang efektif, sikap saling menghormati, dan kolaborasi antarprofesi. Sinergi tersebut sangat diperlukan dalam sistem pelayanan kesehatan modern yang kompleks dan multidisipliner untuk menjamin kontinuitas serta kualitas asuhan kesehatan (Reeves et al., 2021).

Dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan harus berjalan seiring dengan pembinaan profesionalisme. Pendidikan kesehatan kontemporer tidak hanya berfokus pada pencapaian kompetensi klinis, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai profesional seperti integritas, empati, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Pendekatan ini penting agar tenaga kesehatan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berubah (Labrague et al., 2024; Cruess & Cruess, 2023).

Dengan demikian, kompetensi dan profesionalisme merupakan dua pilar utama yang saling melengkapi dalam praktik pelayanan kesehatan. Integrasi yang kuat antara keduanya menjadi kunci dalam peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

## **H. Penerapan Kompetensi dan Profesionalisme dalam Pelayanan Kesehatan**

---

Penerapan kompetensi dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan mencerminkan kemampuan nyata tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kompetensi tidak semata-mata dimaknai sebagai penguasaan pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga mencakup kemampuan mengintegrasikan sikap profesional, nilai-nilai etika, serta pertimbangan situasional dalam praktik sehari-hari. Profesionalisme berfungsi sebagai kerangka nilai yang mengarahkan pemanfaatan kompetensi tersebut agar selaras dengan standar profesi, norma etik, dan kepentingan terbaik pasien (Thirumoorthy et al., 2025).

Dalam praktik klinis, penerapan kompetensi tercermin melalui kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan pengkajian menyeluruh, menetapkan diagnosis secara tepat, merencanakan dan melaksanakan intervensi berbasis bukti, serta mengevaluasi hasil asuhan secara sistematis dan berkelanjutan. Profesionalisme memastikan bahwa seluruh tahapan proses asuhan tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keselamatan pasien, penghormatan terhadap martabat dan otonomi pasien, serta tanggung jawab moral atas setiap keputusan dan tindakan klinis yang diambil (Frank et al., 2023).

Lebih lanjut, profesionalisme diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kode etik dan standar praktik profesi. Tenaga kesehatan dituntut untuk bertindak jujur, menjaga kerahasiaan informasi pasien, menghindari konflik kepentingan, serta memberikan pelayanan yang adil dan non-diskriminatif. Dalam konteks ini, kompetensi etik dan komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik profesional, karena kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan, kepuasan, dan hasil pelayanan kesehatan (Pakkanen et al., 2023).

Penerapan kompetensi dan profesionalisme juga memiliki peran krusial dalam kerja tim interprofesional. Kompleksitas permasalahan kesehatan pada sistem pelayanan modern menuntut kolaborasi yang efektif antarprofesi. Kompetensi memungkinkan setiap tenaga kesehatan menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan lingkup praktik, sementara profesionalisme mendorong terciptanya komunikasi yang terbuka, sikap saling menghormati, serta pengambilan keputusan bersama yang berfokus pada kepentingan pasien (Reeves et al., 2021).

Dalam tataran organisasi dan sistem kesehatan, penerapan kompetensi dan profesionalisme berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan. Tenaga kesehatan yang profesional tidak hanya menjalankan peran klinis, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan mutu, audit klinis, serta pengembangan praktik berbasis bukti.

Komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan refleksi diri menjadi elemen penting profesionalisme untuk memastikan kompetensi tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan pelayanan kesehatan yang terus berubah (Labrague et al., 2024).

Dengan demikian, penerapan kompetensi dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu proses integratif yang melibatkan dimensi klinis, etika, komunikasi, dan kolaborasi. Keterpaduan keduanya menjadi landasan utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi, aman, serta berorientasi pada kebutuhan pasien dan masyarakat secara luas.

## **I. Tantangan Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan di Era Modern**

---

### **1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan**

Kemajuan yang sangat cepat dalam ilmu kesehatan dan teknologi medis, termasuk pemanfaatan digital health, rekam medis elektronik, serta layanan telemedicine, menuntut tenaga kesehatan untuk senantiasa memperbarui dan menyesuaikan kompetensinya. Ketidakmampuan mengikuti perkembangan teknologi tersebut dapat menyebabkan kesenjangan kompetensi yang berpotensi menurunkan mutu pelayanan serta meningkatkan risiko terhadap keselamatan pasien.

### **2. Tuntutan Praktik Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*)**

Tenaga kesehatan di era modern dituntut memiliki kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengimplementasikan temuan ilmiah terkini dalam pengambilan keputusan klinis. Tantangan dalam penerapan praktik berbasis bukti sering muncul akibat keterbatasan waktu, akses terhadap sumber ilmiah, serta kemampuan literasi riset yang belum merata, sehingga berdampak pada optimalisasi mutu asuhan kesehatan.

### **3. Beban Kerja Tinggi dan Keterbatasan Sumber Daya**

Tingginya beban kerja pelayanan, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, serta kompleksitas tuntutan administratif dapat mengurangi kesempatan tenaga kesehatan untuk melakukan pengembangan diri dan refleksi profesional. Kondisi ini meningkatkan risiko kelelahan kerja atau burnout, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas kompetensi dan konsistensi profesionalisme dalam praktik pelayanan.

### **4. Kompleksitas Permasalahan Etika dan Hukum Kesehatan**

Perubahan sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, disertai meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, memunculkan berbagai dilema etika dan hukum. Isu seperti perlindungan privasi dan kerahasiaan pasien,

informed consent, konflik kepentingan, serta pengambilan keputusan klinis dalam kondisi terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga profesionalisme tenaga kesehatan.

#### **5. Perubahan Karakteristik dan Ekspektasi Pasien**

Pasien saat ini cenderung lebih kritis, memiliki akses informasi yang luas, dan menuntut kualitas pelayanan yang tinggi. Kondisi ini menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya unggul secara klinis, tetapi juga mampu menunjukkan profesionalisme melalui komunikasi yang efektif, empati, serta keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan pelayanan.

#### **6. Tantangan dalam Kolaborasi Interprofesional**

Pelayanan kesehatan modern menekankan pentingnya kerja tim multidisipliner. Perbedaan latar belakang pendidikan, peran profesional, dan budaya kerja antarprofesi dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi yang efektif apabila tidak diimbangi dengan sikap profesional, komunikasi terbuka, dan saling menghargai.

#### **7. Kesenjangan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan**

Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan belum merata bagi seluruh tenaga kesehatan, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan perbedaan tingkat kompetensi dan kualitas pelayanan kesehatan antarwilayah.

#### **8. Adaptasi terhadap Perubahan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan**

Dinamika kebijakan, regulasi, dan standar pelayanan kesehatan yang terus berkembang menuntut tenaga kesehatan untuk selalu menyesuaikan kompetensi dan praktik profesionalnya. Ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi dapat berdampak pada ketidaksesuaian praktik dengan standar yang berlaku.

#### **9. Pemeliharaan Profesionalisme di Tengah Tekanan Kerja**

Tekanan waktu, tuntutan organisasi, serta kondisi kerja yang menantang dapat memengaruhi konsistensi penerapan nilai-nilai profesional, seperti integritas, empati, dan tanggung jawab. Menjaga profesionalisme dalam situasi tersebut menjadi tantangan penting dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari.

#### **10. Komitmen terhadap Pembelajaran Sepanjang Hayat**

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan adalah mempertahankan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Tenaga kesehatan dituntut untuk terus belajar, melakukan refleksi diri, dan mengembangkan kapasitas profesional secara

berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

## **J. Upaya Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan**

---

Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan merupakan strategi fundamental untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta keberlanjutan sistem kesehatan di era modern. Pengembangan kompetensi harus dilakukan secara seimbang dengan pembinaan profesionalisme agar tenaga kesehatan tidak hanya unggul secara teknis dan klinis, tetapi juga mampu menerapkan nilai etika, tanggung jawab moral, serta orientasi pelayanan yang berpusat pada pasien (Frank et al., 2023; WHO, 2022).

### **1. Penguatan Pendidikan dan Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dimulai melalui penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada capaian pembelajaran berbasis kompetensi. Kurikulum pendidikan kesehatan perlu disusun selaras dengan standar kompetensi nasional dan internasional serta mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, keterampilan klinis, dan sikap profesional. Pendekatan pembelajaran aktif, seperti problem-based learning dan simulation-based education, terbukti efektif dalam membentuk kompetensi klinis dan profesionalisme sejak tahap pendidikan awal (Frank et al., 2023; Shorey & Ng, 2023).

### **2. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*)**

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan upaya utama dalam mempertahankan dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Melalui CPD, tenaga kesehatan dapat memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta menyesuaikan praktik profesional dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Peran organisasi profesi dan institusi pelayanan kesehatan sangat penting dalam menjamin ketersediaan dan pemerataan akses terhadap program CPD yang berkualitas (WHO, 2022; Davis et al., 2021).

### **3. Pembinaan Profesionalisme dan Etika Profesi**

Peningkatan profesionalisme dilakukan melalui internalisasi nilai etika, integritas, empati, serta tanggung jawab profesional dalam praktik pelayanan kesehatan. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pelatihan etika klinis, diskusi kasus etik, serta penegakan kode etik profesi secara konsisten. Lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai profesional terbukti berkontribusi positif terhadap



perilaku etis tenaga kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan (Pakkanen et al., 2023; Thirumoorthy et al., 2025).

#### **4. Penguatan Praktik Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*)**

Pengembangan kompetensi tenaga kesehatan juga mencakup penguatan kemampuan dalam menerapkan praktik berbasis bukti. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan literasi riset, kemudahan akses terhadap sumber ilmiah, serta pelatihan dalam penilaian kritis bukti penelitian. Penerapan evidence-based practice mendukung pengambilan keputusan klinis yang rasional, aman, dan efektif sesuai kebutuhan pasien (Melnik & Fineout-Overholt, 2023).

#### **5. Pengembangan Kompetensi Komunikasi dan Kolaborasi Interprofesional**

Pelayanan kesehatan modern menuntut kerja sama tim multidisipliner yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi komunikasi dan kolaborasi interprofesional menjadi bagian penting dalam pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan. Program interprofessional education (IPE) terbukti mampu meningkatkan pemahaman peran antarprofesi, kualitas komunikasi, serta keselamatan pasien dalam praktik pelayanan kesehatan (Reeves et al., 2021).

#### **6. Penciptaan Lingkungan Kerja yang Mendukung Pembelajaran Berkelanjutan**

Lingkungan kerja yang kondusif, suportif, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan memiliki peran besar dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan. Dukungan kepemimpinan, sistem supervisi yang efektif, serta budaya refleksi dan umpan balik konstruktif dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan komitmen profesional tenaga kesehatan (Labrague et al., 2024).

#### **7. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengembangan Kompetensi**

Pemanfaatan teknologi digital, seperti e-learning, simulasi virtual, dan platform pembelajaran daring, menjadi strategi penting dalam pengembangan kompetensi tenaga kesehatan. Teknologi memungkinkan proses pembelajaran yang fleksibel, berkelanjutan, dan menjangkau tenaga kesehatan di berbagai wilayah, termasuk daerah dengan keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan (WHO, 2022).

#### **8. Penguatan Regulasi, Sertifikasi, dan Penilaian Kinerja**

Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme juga didukung oleh sistem regulasi, sertifikasi, dan evaluasi kinerja yang jelas dan konsisten. Uji kompetensi, resertifikasi berkala, serta penilaian kinerja berbasis standar profesi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar (Kementerian Kesehatan RI, 2023; Frank et al., 2023).

## K. Simpulan

---

Kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan merupakan dua pilar utama yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berfokus pada kebutuhan pasien. Kompetensi menggambarkan kapasitas menyeluruh tenaga kesehatan dalam memadukan pengetahuan ilmiah, keterampilan klinis, serta sikap profesional untuk memberikan asuhan yang efektif sesuai dengan standar praktik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, profesionalisme menunjukkan cara kompetensi tersebut diwujudkan dalam praktik melalui perilaku etis, integritas, tanggung jawab moral, serta komitmen yang kuat terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, kompetensi berfungsi sebagai dasar kemampuan teknis dan klinis yang memungkinkan tenaga kesehatan melakukan pengkajian, pengambilan keputusan, dan intervensi secara tepat serta berbasis bukti. Namun, penerapan kompetensi tanpa didasari profesionalisme yang memadai berpotensi mengabaikan nilai-nilai etika, empati, dan penghormatan terhadap hak pasien. Sebaliknya, profesionalisme yang tidak disertai kompetensi yang cukup dapat meningkatkan risiko kesalahan klinis dan menurunkan mutu pelayanan. Oleh karena itu, keterpaduan antara kompetensi dan profesionalisme merupakan syarat esensial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi kesehatan, dan meningkatnya kompleksitas sistem pelayanan, tenaga kesehatan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi sekaligus mempertahankan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Upaya tersebut perlu didukung oleh sistem pendidikan berbasis kompetensi, pembinaan etika profesi yang konsisten, lingkungan kerja yang mendukung, serta regulasi dan standar profesi yang jelas. Dengan penguatan kompetensi dan profesionalisme secara berkesinambungan, tenaga kesehatan diharapkan mampu menghadapi tantangan pelayanan kesehatan modern, meningkatkan keselamatan serta kepuasan pasien, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

## L. Referensi

---

- Ali, A. A., & Khalifa, M. A. (2025). Professional competence, moral courage, and communication effectiveness among nurses: Implications for patient safety and quality of care. *Journal of Nursing Management*, 33(1), 45–56.
- Alnasser, A. H. (2024). Professionalism in healthcare practice: Integrating ethics, patient safety, and quality of care. *BMC Medical Education*, 24(1), 1–9.
- Alnasser, Y. M. (2024). Profesionalisme dan kompetensi etis dalam praktik kesehatan. *BMC Health Services Research*, 24(1), 1–9.
- Cruess, R. L., Cruess, S. R., & Steinert, Y. (2022). Medicine as a profession: A renewed focus on professionalism. *Medical Education*, 56(9), 840–848.
- Cruess, R. L., Cruess, S. R., & Steinert, Y. (2022). Mengajar profesionalisme medis: Mendukung pengembangan identitas profesional (ed. ke-2). Cambridge University Press.
- Cruess, S. R., & Cruess, R. L. (2023). Professionalism and medicine's social contract. *Perspectives on Medical Education*, 12(1), 12–18.
- Davis, D. A., Bordage, G., Moores, L. K., et al. (2021). Pengembangan profesional berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup dalam layanan kesehatan. *BMJ*, 372, 826.
- Erfani, G., McCready, J., Gibson, B., et al. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi kesehatan digital di kalangan profesional kesehatan. *Applied Nursing Research*, 62, 151922.
- Frank, J. R., Snell, L., & Sherbino, J. (2023). CanMEDS 2025 physician competency framework. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
- Frank, J. R., Snell, L., & Sherbino, J. (2023). Competency-based medical education and professionalism in health professions. *Academic Medicine*, 98(1), 34–41.
- Frank, J. R., Snell, L., Englander, R., & Holmboe, E. S. (2023). Implementing competency-based medical education: Moving forward. *Medical Teacher*, 45(1), 1–8.
- Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., et al. (2022). Health professionals for a new century: Transforming education to strengthen health systems. *The Lancet*, 399(10336), 1927–1958.

- Govaerts, M. J. B., van der Vleuten, C. P. M., & Holmboe, E. (2021). Managing clinical performance: Competence, capability, and patient safety. *Medical Education*, 55(1), 76–86.
- Haruta, J., & Richardson, G. (2023). Factors associated with interprofessional competencies among healthcare professionals. *Journal of Interprofessional Care*, 37(8), 123–131.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pengembangan sumber daya manusia kesehatan dalam transformasi sistem kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Labrague, L. J., De los Santos, J. A. A., & Falguera, C. C. (2024). Professional competence, lifelong learning, and quality of healthcare practice among health professionals. *Journal of Nursing Management*, 32(1), 45–54. <https://doi.org/10.1111/jonm.13980>
- Labrague, L. J., et al. (2024). Professional competence and patient safety in healthcare practice. *Journal of Nursing Management*, 32(2), 345–353.
- Ong, L. M. L., de Haes, J. C. J. M., Hoos, A. M., & Lammes, F. B. (2020). Doctor–patient communication and patient outcomes. *Patient Education and Counseling*, 103(1), 1–9.
- Pakkanen, P., Häggman-Laitila, A., Pasanen, M., & Kangasniemi, M. (2023). Health and social care workers' professional values: A cross-sectional study. *Nursing Ethics*, 31(5), 681–698. <https://doi.org/10.1177/09697330231200569>
- Pakkanen, P., Leino-Kilpi, H., Numminen, O., & Isoaho, H. (2023). Health and social care workers' professional values: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09145-6>
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2021). Interprofessional collaboration to improve healthcare outcomes. *Journal of Interprofessional Care*, 35(2), 1–10.
- Sadeq, A., Guraya, S. S., Fahey, B., et al. (2025). Medical professionalism education: A systematic review of interventions, outcomes, and sustainability. *Frontiers in Medicine*, 12, 1522411. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1522411>
- Thirumoorthy, T., & Shelat, V. G. (2025). Understanding medical professionalism. *Singapore Medical Journal*, 66 (2), 114–118. <https://doi.org/10.4103/singaporemedj.SMJ-2023-059>

- Thirumoorthy, T., Goh, L. G., Pang, S. M., & Tan, P. L. (2025). Understanding medical professionalism. *Journal of Medical Ethics and Professionalism*, 18(1), 12–20.
- Toto, S. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi perawatan berpusat pada pasien: Tinjauan scoping. *Journal of Research in Kesehatan (JRK)*.
- Wei, H., Roberts, P., Strickler, J., & Corbett, R. W. (2022). Nurse professionalism and patient-centered care. *Journal of Nursing Scholarship*, 54(3), 289–298.
- World Health Organization. (2022). Global competency and professionalism standards for health workers. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2022). Global strategy on human resources for health: Workforce 2030 – progress and implementation update. Geneva: World Health Organization.

## **M. Glosarium**

---

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Evidence-Based Practice</i> | : Praktik Berbasis Bukti    |
| WHO                            | : World Health Organization |
| STR                            | : Surat Tanda Registrasi    |
| SIP                            | : Surat Izin Praktik        |

# CHAPTER 2

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KEBIDANAN

Deasy Elvianita, S.ST., M.Keb

### A. Pendahuluan / Prolog

Pengembangan kompetensi tenaga kebidanan merupakan elemen krusial dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkesinambungan. Bidan sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki peran yang sangat strategis dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi, mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan perempuan. Oleh sebab itu, bidan dituntut untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya memenuhi standar profesi, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Kemp et al., 2021; Tangkas et al., 2025).

Perubahan sistem pelayanan kesehatan, kemajuan teknologi medis, serta meningkatnya tuntutan mutu pelayanan menjadikan pengembangan kompetensi sebagai kebutuhan yang bersifat berkelanjutan. Kompetensi tenaga kebidanan tidak hanya mencakup keterampilan klinis, tetapi juga meliputi aspek komunikasi, etika profesional, manajemen pelayanan, keselamatan pasien, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis (Organization, 2020). Tanpa pengembangan kompetensi yang sistematis dan terarah, kualitas pelayanan kebidanan berpotensi mengalami kesenjangan dengan standar yang diharapkan.

Selain itu, tantangan globalisasi dan implementasi standar pelayanan kesehatan nasional maupun internasional menuntut bidan untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, supervisi klinis, serta praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*). Pengembangan kompetensi juga menjadi bagian penting dalam mendukung profesionalisme bidan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan primer (Embo et al., 2025).

## **B. Konsep Kompetensi Tenaga Kebidanan**

---

Kompetensi tenaga kebidanan merupakan kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku profesional yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kebidanan secara efektif dan aman. Kompetensi ini mencerminkan kemampuan bidan dalam melaksanakan praktik sesuai standar profesi dan kode etik (Embo et al., 2025; Tangkas et al., 2025). Secara umum, kompetensi kebidanan mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

### **1. Kompetensi Klinis**

Kompetensi klinis mencakup kemampuan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif sepanjang siklus reproduksi perempuan, yang meliputi masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir, hingga pelayanan keluarga berencana. Kompetensi tersebut menuntut penguasaan keterampilan dalam melakukan pemeriksaan kebidanan, penegakan diagnosis, pelaksanaan tindakan pertolongan persalinan, serta kemampuan melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya komplikasi.

### **2. Kompetensi Komunikasi dan Konseling**

Bidan harus mampu melakukan komunikasi terapeutik, memberikan edukasi kesehatan, serta melakukan konseling kepada klien dan keluarga. Kompetensi ini sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan klien terhadap pelayanan kesehatan.

### **3. Kompetensi Profesionalisme**

Kompetensi profesional meliputi sikap etis, tanggung jawab, kepatuhan terhadap standar praktik, serta komitmen terhadap keselamatan pasien. Kompetensi ini juga mencerminkan integritas bidan dalam menjalankan praktik secara akuntabel, menghormati hak dan martabat klien, serta menjaga kerahasiaan informasi kesehatan. Selain itu, profesionalisme menuntut kemampuan bidan untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim kesehatan, mengambil keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan pertimbangan ilmiah dan etika, serta menunjukkan komitmen terhadap pengembangan diri secara berkelanjutan guna mempertahankan mutu pelayanan kebidanan.

### **4. Kompetensi Manajerial**

Bidan juga dituntut memiliki kemampuan manajemen pelayanan, pengorganisasian sumber daya, serta pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan kebidanan. Kemampuan manajerial tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan kebidanan secara sistematis guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan. Selain itu, bidan diharapkan mampu mengelola informasi kesehatan secara akurat dan terdokumentasi dengan baik sebagai dasar pengambilan keputusan klinis, peningkatan mutu

pelayanan, serta pemenuhan aspek akuntabilitas dalam sistem pelayanan kesehatan.

### 5. Kompetensi *Evidence-Based Practice*

Bidan dituntut mampu memanfaatkan hasil penelitian dan bukti ilmiah secara sistematis dalam proses pengambilan keputusan klinis sebagai upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kebidanan. Penerapan praktik berbasis bukti tersebut menuntut kemampuan bidan dalam menelaah literatur ilmiah secara kritis, mengintegrasikan temuan penelitian dengan pengalaman klinis, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi klien. Melalui pendekatan ini, pelayanan kebidanan diharapkan menjadi lebih rasional, terstandar, dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta tuntutan kualitas pelayanan kesehatan modern.

## C. Standar Kompetensi Bidan

Standar kompetensi tenaga kebidanan berfungsi sebagai acuan utama dalam pendidikan, praktik, dan evaluasi kinerja bidan. Di Indonesia, standar ini disusun berdasarkan kebijakan nasional dan diselaraskan dengan standar internasional, sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Standar Kompetensi Bidan**

| Area Kompetensi        | Deskripsi                                             | Acuan Standar    |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Kompetensi Klinis      | Kemampuan memberikan asuhan kebidanan komprehensif    | ICM, Kemenkes RI |
| Kompetensi Komunikasi  | Kemampuan komunikasi terapeutik dan edukasi kesehatan | ICM              |
| Kompetensi Profesional | Penerapan etika dan hukum kebidanan                   | Kemenkes RI      |

Kompetensi bidan mencakup beberapa area utama:

1. Asuhan kebidanan pada masa kehamilan
2. Asuhan persalinan normal
3. Asuhan nifas dan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan reproduksi
5. Pelayanan keluarga berencana
6. Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit



Standar kompetensi juga menekankan pentingnya kemampuan kolaborasi interprofesional serta penerapan prinsip keselamatan pasien (M. D. Fraser & Cooper, 2003).

#### **D. Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Kompetensi Bidan**

---

Pengembangan kompetensi tenaga kebidanan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Aspek Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting, baik yang diperoleh melalui jalur pendidikan formal maupun melalui program pengembangan profesional berkelanjutan. Pendidikan yang bermutu memiliki peran strategis dalam membentuk dasar pengetahuan, keterampilan klinis, serta sikap profesional bidan sehingga mampu memberikan pelayanan kebidanan yang aman, efektif, dan sesuai standar praktik (Embo et al., 2025; M. D. Fraser & Cooper, 2003).

Selain itu, pengalaman praktik klinis juga merupakan faktor penting dalam peningkatan kompetensi. Melalui pengalaman langsung di lapangan, bidan dapat memperkuat keterampilan teknis, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan klinis, serta membangun kepercayaan diri dalam memberikan asuhan kebidanan (D. M. Fraser et al., 2009).

Faktor lain yang berpengaruh adalah dukungan institusi, baik dari fasilitas pelayanan kesehatan maupun organisasi profesi. Dukungan ini dapat berupa penyediaan pelatihan, supervisi klinis, sistem mentoring, serta kesempatan pengembangan karier yang berkelanjutan bagi bidan (Tangkas et al., 2025).

Di samping itu, motivasi individu juga memegang peranan penting dalam pengembangan kompetensi. Dorongan internal untuk terus belajar, memperbarui pengetahuan, serta meningkatkan kualitas pelayanan menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan kompetensi profesional bidan.

#### **E. Kerangka Teori Pengembangan Kompetensi Tenaga Kebidanan**

---

Pengembangan kompetensi tenaga kebidanan dapat dijelaskan melalui pendekatan teori kompetensi berbasis outcome yang menekankan integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam praktik pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2024). Dalam konteks kebidanan, kompetensi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, serta pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) (Emi Nurjismi, 2020). Selain itu, teori experiential learning menegaskan bahwa pengalaman praktik klinis merupakan sumber utama peningkatan kompetensi profesional bidan (Kolb, 2014).

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi tidak hanya berfokus pada penguasaan aspek kognitif, tetapi juga pada kemampuan

reflektif dan adaptif dalam menghadapi situasi klinis yang kompleks. Melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan, bidan diharapkan mampu mengevaluasi pengalaman praktik, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri, serta menyesuaikan praktik pelayanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Dengan demikian, pengembangan kompetensi menjadi suatu proses dinamis yang menuntut keterlibatan aktif individu, dukungan sistem pendidikan, serta lingkungan praktik yang kondusif (Education, 2013; Embo et al., 2025).

## **F. Strategi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kebidanan**

---

Pengembangan kompetensi bidan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain (Organization, 2019):

### **1. Pendidikan Berkelanjutan**

Pengembangan kompetensi bidan harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui Continuing Professional Development (CPD). CPD bertujuan menjaga dan meningkatkan kompetensi sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan CPD meliputi pelatihan klinis, seminar ilmiah, workshop keterampilan, serta sertifikasi kompetensi yang diakui oleh organisasi profesi.

### **2. Pelatihan Klinis Berbasis Kompetensi**

Pelatihan berbasis kompetensi menekankan praktik langsung dan evaluasi keterampilan.

### **3. Mentoring dan Supervisi**

Program mentoring membantu bidan junior memperoleh pengalaman dan bimbingan dari bidan senior.

### **4. Penggunaan Teknologi Digital**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan kebidanan memberikan peluang pengembangan kompetensi yang lebih luas dan fleksibel. E-learning, telemedicine, dan simulasi digital menjadi bagian integral dalam pembelajaran modern (Frenk et al., 2010).

## **G. Peran Organisasi Profesi Dalam Pengembangan Kompetensi Bidan**

---

Organisasi profesi kebidanan memiliki peran penting dalam menjaga mutu pelayanan melalui:

### **1. Penetapan standar praktik**

Penetapan standar praktik merupakan salah satu peran strategis organisasi profesi dalam menjamin mutu pelayanan kebidanan. Standar praktik berfungsi sebagai pedoman bagi bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan sesuai dengan prinsip evidence-based practice. Melalui standar yang

jelas dan terukur, bidan memiliki acuan dalam menjalankan kewenangan profesional, menjaga keselamatan pasien, serta mempertahankan konsistensi kualitas pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan.

## **2. Sertifikasi kompetensi**

Sertifikasi kompetensi menjadi mekanisme penting dalam memastikan bahwa bidan memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan. Proses sertifikasi dilakukan melalui penilaian yang sistematis terhadap aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Dengan adanya sertifikasi, kualitas tenaga kebidanan dapat terjaga, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

## **3. Program pelatihan berkelanjutan**

Program pelatihan berkelanjutan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan dan memperbarui kompetensi bidan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Kegiatan ini dapat berupa pelatihan klinis, seminar ilmiah, workshop, maupun pendidikan lanjutan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis, manajerial, serta profesionalisme bidan. Pelatihan berkelanjutan juga berperan dalam meningkatkan adaptasi bidan terhadap dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

## **4. Advokasi kebijakan kesehatan**

Organisasi profesi memiliki peran penting dalam melakukan advokasi kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan praktik kebidanan dan perlindungan tenaga bidan. Melalui fungsi advokasi, organisasi profesi dapat berkontribusi dalam penyusunan regulasi, peningkatan kesejahteraan tenaga kebidanan, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak. Keterlibatan ini juga mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu layanan kebidanan secara berkelanjutan.

Organisasi profesi secara keseluruhan berperan signifikan dalam meningkatkan profesionalisme, menjaga etika praktik, serta memastikan bahwa bidan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar moral, hukum, dan tanggung jawab sosial profesi.

## **H. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Bidan**

---

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan kompetensi tenaga kebidanan sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pendidikan kebidanan, penetapan standar kompetensi profesi, serta pengaturan praktik kebidanan yang bertujuan menjamin kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2024).

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan berbagai program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi bidan guna memastikan bahwa kompetensi tenaga kebidanan tetap terjaga dan berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya ini mencakup penyelenggaraan pelatihan klinis, peningkatan kapasitas tenaga pendidik kebidanan, serta penguatan sistem sertifikasi kompetensi nasional. Peran pemerintah juga terlihat dalam upaya pemerataan akses pengembangan kompetensi bagi bidan di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Kebijakan distribusi tenaga kesehatan, pemberian insentif, serta penyediaan fasilitas pelatihan berbasis teknologi menjadi strategi penting dalam mengurangi kesenjangan kualitas pelayanan kebidanan antar wilayah (Nakes & Kemenkes, 2020).

Di samping itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kompetensi bidan melalui mekanisme akreditasi institusi pendidikan, penilaian kinerja tenaga kesehatan, serta pengawasan mutu pelayanan kebidanan. Sistem evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa bidan mampu mempertahankan standar praktik profesional serta memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas.

Lebih lanjut, pemerintah juga berperan dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan institusi pendidikan, organisasi profesi, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem pengembangan kompetensi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan Masyarakat (Organization, 2021).

## **I. Indikator Keberhasilan Pengembangan Kompetensi Bidan**

---

Keberhasilan pengembangan kompetensi tenaga kebidanan dapat dinilai melalui berbagai indikator yang mencerminkan peningkatan kualitas kinerja profesional. Salah satu indikator utama adalah peningkatan kemampuan klinis bidan dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif, aman, dan sesuai standar praktik. Selain itu, kualitas dokumentasi pelayanan yang lebih sistematis dan akurat juga menjadi bukti adanya peningkatan kompetensi profesional bidan (Renfrew et al., 2014; World Health Organization, 2024).

Indikator lainnya adalah meningkatnya kepatuhan terhadap standar praktik kebidanan, yang mencakup penerapan prosedur operasional, prinsip etika profesi, serta keselamatan pasien dalam setiap tindakan pelayanan. Peningkatan kompetensi juga berkontribusi terhadap penurunan risiko kesalahan klinis serta peningkatan kualitas komunikasi terapeutik dengan klien (Tangkas et al., 2025). Lebih lanjut, pengembangan kompetensi bidan memiliki dampak langsung

terhadap keselamatan pasien dan kepuasan klien. Bidan yang kompeten mampu memberikan pelayanan yang responsif, empatik, serta berbasis bukti ilmiah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan.

Selain indikator yang bersifat individual, keberhasilan pengembangan kompetensi bidan juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini meliputi peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak, penurunan angka komplikasi maternal dan neonatal, serta peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan di tingkat primer (Renfrew et al., 2014; WHO, 2022).

Dalam konteks manajemen mutu pelayanan kesehatan, indikator keberhasilan kompetensi bidan juga dapat diukur melalui penilaian kinerja, audit klinis, serta evaluasi berkelanjutan yang dilakukan oleh institusi pelayanan kesehatan maupun organisasi profesi. Sistem monitoring tersebut penting untuk memastikan bahwa kompetensi bidan terus berkembang sesuai dengan tuntutan standar pelayanan kesehatan modern (World Health Organization, 2024).

## **J. Dampak Pengembangan Kompetensi Terhadap Kualitas Pelayanan**

---

Pengembangan kompetensi tenaga kebidanan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bidan yang memiliki kompetensi yang baik mampu memberikan asuhan kebidanan yang lebih efektif, aman, dan sesuai standar praktik, sehingga berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kebidanan secara keseluruhan (Embo et al., 2025).

Peningkatan kompetensi bidan juga berperan dalam menurunkan risiko terjadinya komplikasi maternal dan neonatal melalui kemampuan deteksi dini, penanganan yang tepat, serta rujukan yang cepat dan efektif (3,4). Selain itu, kompetensi yang memadai turut mendukung penerapan prinsip keselamatan pasien dalam praktik kebidanan (Organization, 2022).

Dari perspektif pelayanan, bidan yang kompeten mampu membangun komunikasi yang baik, memberikan pelayanan yang responsif, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien terhadap layanan kesehatan. Secara lebih luas, pengembangan kompetensi bidan juga berkontribusi dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional, khususnya dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi (Renfrew et al., 2014).

## **K. Pengembangan Kompetensi Dalam Perspektif Akreditasi**

---

Dalam kerangka akreditasi pendidikan dan pelayanan kesehatan, pengembangan kompetensi tenaga kebidanan merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian mutu institusi. Lembaga pendidikan maupun fasilitas pelayanan kesehatan dituntut untuk menjamin ketersediaan sistem yang terstruktur dalam memantau, menilai, dan meningkatkan kompetensi bidan secara berkesinambungan (Kebudayaan, 2020).

Selain itu, proses monitoring dan evaluasi kompetensi yang dilakukan secara kontinu diperlukan untuk memastikan bahwa bidan mampu mempertahankan standar praktik profesional serta memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan Masyarakat (World Health Organization, 2013).

## **L. Tantangan dan Strategi**

---

Pengembangan kompetensi bidan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun sistemik. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, khususnya bagi bidan yang bertugas di daerah dengan sumber daya terbatas (Organization, 2019). Selain itu, tingginya beban kerja pelayanan juga dapat menghambat kesempatan bidan untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesional secara optimal (Renfrew et al., 2014).

Tantangan lainnya meliputi kesenjangan kualitas pendidikan kebidanan antar institusi serta keterbatasan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat mempengaruhi proses peningkatan kompetensi bidan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang melibatkan institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi profesi untuk mendukung pengembangan kompetensi bidan secara berkelanjutan dan merata (Embo et al., 2025; Emi Nurjasmi, 2020).

## **M. Simpulan**

---

Pengembangan kompetensi tenaga kebidanan merupakan proses yang bersifat fundamental dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kompetensi bidan tidak hanya mencakup aspek klinis, tetapi juga meliputi kemampuan komunikasi, profesionalisme, manajerial, serta penerapan praktik berbasis bukti ilmiah. Penguasaan kompetensi yang komprehensif menjadi landasan utama bagi bidan dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar praktik profesional.

Pengembangan kompetensi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pendidikan dan pelatihan, pengalaman praktik klinis, dukungan institusi, serta motivasi individu. Upaya peningkatan kompetensi juga memerlukan strategi yang terintegrasi melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan berbasis kompetensi, mentoring, supervisi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Selain itu, keterlibatan organisasi profesi dan pemerintah memiliki peran strategis dalam penetapan standar praktik, sertifikasi kompetensi, penyusunan kebijakan, serta penyediaan program pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Keberhasilan pengembangan kompetensi bidan dapat dilihat dari peningkatan kualitas kinerja klinis, kepatuhan terhadap standar praktik, keselamatan pasien, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan. Secara lebih luas, kompetensi bidan yang optimal berkontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu sistem pelayanan kesehatan, menurunkan angka komplikasi maternal dan neonatal, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Dengan demikian, pengembangan kompetensi tenaga kebidanan harus dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, dan kolaboratif guna memastikan bidan mampu menghadapi dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan modern serta mempertahankan profesionalisme dalam praktik kebidanan.

## N. Referensi

---

- Education, P. (2013). *Transforming and Scaling up Health Professional Education and Training*.
- Embo, M., Levy, C., & Pairman, S. (2025). The international confederation of midwives essential competencies for midwifery practice: A revision process - 2024. *Midwifery*, 149, 104525. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2025.104525>
- Emi Nurjasmi, dkk. (2020). *Standar profesi bidan*.
- Fraser, D. M., Cooper, M. A., & Fletcher, G. (2009). Buku ajar bidan myles. *Jakarta: EGC*, 508–509.
- Fraser, M. D., & Cooper, M. A. (2003). Myles text book for midwives. *Midwifery*, 33(3), 752.
- Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., Fineberg, H., Garcia, P., Ke, Y., & Kelley, P. (2010). Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. *The Lancet*, 376(9756), 1923–1958.
- Kebudayaan, K. P. D. (2020). Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. *Jakarta: Kemendikbud*.

- Kemp, J., Maclean, G. D., & Moyo, N. (2021). *Global midwifery: Principles, policy and practice*. Springer.
- Kolb, D. A. (2014). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. FT press.
- Nakes, D., & Kemenkes, R. I. (2020). *Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024*. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- Organization, W. H. (2019). *Strengthening quality midwifery education for universal health coverage 2030*.
- Organization, W. H. (2020). *Regional Strategic Directions for strengthening Midwifery in the South-East Asia Region 2020–2024*. World Health Organization. Regional Office for South-East Asia.
- Organization, W. H. (2021). *Global strategic directions for nursing and midwifery 2021-2025*. World Health Organization.
- Organization, W. H. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. World Health Organization.
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., Silva, D. R. A. D., Downe, S., Kennedy, H. P., & McCormick, F. (2014). Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145.
- Tangkas, B. N. M. K. S., Kusumaningrum, B. H., ST, S., Keb, M., Lutfiana, B. I., ST, S., Dewianti, B. N. M., & ST, S. (2025). *Buku Standar Profesi Bidan*. Mahakarya Citra Utama Group.
- WHO. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2013). *Midwifery educator core competencies*. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.
- World Health Organization. (2024). *ICM Essential Competencies for Midwifery Practice*.

## O. Glosarium

---

|            |             |                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akreditasi | =           | Proses penilaian mutu secara sistematis terhadap institusi pendidikan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. |
| Asuhan     | Kebidanan = | Serangkaian pelayanan profesional yang diberikan bidan kepada perempuan sepanjang siklus reproduksi, meliputi masa prakonsepsi, kehamilan,                                 |



|                                   |                             |   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                             |   | persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana.                                                                                                |
| Deteksi Dini                      | Komplikasi                  | = | Upaya identifikasi awal terhadap tanda dan gejala yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan ibu dan bayi agar dapat dilakukan penanganan tepat waktu. |
| Kompetensi                        | Kebidanan                   | = | Gabungan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku profesional yang diperlukan bidan untuk memberikan pelayanan kebidanan secara aman dan efektif.    |
| Kompetensi Klinis                 |                             | = | Kemampuan teknis bidan dalam melakukan pemeriksaan, diagnosis, tindakan, serta penatalaksanaan asuhan kebidanan.                                           |
| Kompetensi Profesional            |                             | = | Sikap dan perilaku bidan yang mencerminkan etika profesi, tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan terhadap standar praktik.                              |
| Kompetensi                        | Manajerial                  | = | Kemampuan bidan dalam mengelola pelayanan, sumber daya, pencatatan, pelaporan, dan koordinasi dalam sistem pelayanan kesehatan.                            |
| Mentoring                         | Klinis                      | = | Proses pembimbingan profesional oleh tenaga kesehatan yang lebih berpengalaman untuk meningkatkan kemampuan praktik tenaga kesehatan lainnya.              |
| Standar                           | Kompetensi                  | = | Kriteria kemampuan minimal yang harus dimiliki tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesional.                                                     |
| Telemedicine                      |                             | = | Pemanfaatan teknologi komunikasi digital dalam pemberian layanan kesehatan jarak jauh.                                                                     |
| Keselamatan<br>( <i>Patient</i> ) | Pasien<br>( <i>Safety</i> ) | = | Prinsip pelayanan kesehatan yang bertujuan mencegah kesalahan dan meminimalkan risiko cedera pada pasien.                                                  |

# CHAPTER 3

## PENGUATAN KOMPETENSI PERAWAT DALAM PRAKTIK PELAYANAN

Dr. Nur Miladiyah Rahmah, S.Kp., M.Kep.

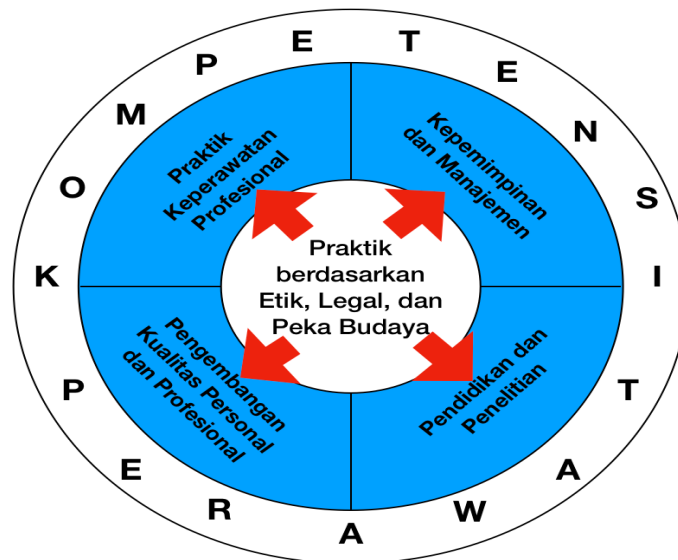
### A. Pendahuluan / Prolog

Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit. Fokus Keperawatan yaitu respons Klien terhadap penyakit, pengobatan, dan lingkungan. Tanggung jawab Perawat yang sangat mendasar yaitu meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan dan mengurangi penderitaan.

Pelayanan Keperawatan merupakan sektor pelayanan jasa yang harus mengikuti perkembangan global. Era globalisasi dalam lingkup perdagangan bebas antarnegara, membawa dampak ganda, di satu sisi membuka kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya, dan di sisi lain membawa dampak persaingan yang cukup ketat. Oleh karena itu, tantangan utama saat ini dan masa mendatang yaitu meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di sektor Keperawatan.

Berdasarkan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (2013) menyusun kerangka kerja kompetensi perawat yang meliputi 3 komponen yaitu (1) praktik profesional etis, legal dan peka budaya, (2) pemberian asuhan dan manajemen asuhan keperawatan, (3) Pengembangan kualitas personal dan profesional. Kerangka kompetensi ini diturunkan dalam standar profesi perawat yang diatur dalam Peraturan Menteri kesehatan No. 425 tahun 2020.

Berdasarkan PMK No 425 tahun 2020, Kompetensi Perawat mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan (*soft* dan *hard skill*). Kerangka kompetensi Perawat dikelompokkan dalam 5 (lima) area kompetensi. Area ini sesuai dengan 5 (lima) *domains of the ASEAN Nursing Common Core Competencies* sebagai berikut: (1) Praktik berdasarkan Etik, Legal, dan Peka Budaya, (2) Praktik Keperawatan Profesional (3) Kepemimpinan dan Manajemen, (4) Pendidikan dan Penelitian, (5) Pengembangan Kualitas Personal dan Profesional



**Gambar 3.1. Area kompetensi Perawat**

Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pasar kerja atau dunia usaha dan industri maka perlu ada Standar Kompetensi Perawat agar terwujud hubungan timbal balik yang positif. Standar Kompetensi Perawat ini dapat digunakan oleh institusi pendidikan, pelayanan kesehatan, lembaga pelatihan, himpunan dan ikatan Keperawatan, dan Pemerintah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

## **B. Penguatan Kompetensi Perawat Dalam Praktik Pelayanan**

Penguatan kompetensi perawat dalam praktik pelayanan keperawatan harus meliputi 4 ranah kompetensi perawat. Penguatan kompetensi perawat di Indonesia di atur dalam peraturan Menteri kesehatan no. 40 tahun 2017 tentang jenjang karir perawat Indonesia. Pengembangan karir profesional perawat dalam bentuk jenjang karir perawat merupakan sistem untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme, sesuai dengan bidang pekerjaan melalui peningkatan kompetensi yang menghasilkan kinerja profesional. Jenjang karir mempunyai makna tingkatan kompetensi untuk melaksanakan asuhan keperawatan yang akuntabel dan etis sesuai batas kewenangan.

### **1. Jenjang karir perawat**

#### **a. Definisi**

Jenjang karir dikembangkan dari teori form novice to expert (Scharton & Benner, 2013), Teori ini mengidentifikasi lima tingkat perkembangan peran dan profesionalisme perawat, yaitu *Novice*, *Advance Beginner*, *Competent*, *Proficient*, dan *Expert* (Benner, 1982).

1. *Novice* (Pemula): Individu tanpa pengalaman sebelumnya, membutuhkan panduan dan aturan yang jelas. Diterapkan pada mahasiswa keperawatan atau perawat yang berada di lingkungan yang tidak familier.

2. *Advance Beginner* (Pemula Tingkat Lanjut): Mampu mengatasi masalah yang dapat diterima dalam situasi nyata. Memiliki pengalaman yang memadai untuk menangani situasi, meskipun masih memerlukan panduan dan aturan.

Tahap 3: Kompeten (*Competent*): Ketika perawat mengumpulkan lebih banyak pengalaman, mereka menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang berbeda. Mereka dapat mengidentifikasi prioritas perawatan, mengambil keputusan yang lebih mandiri, dan Perawat dapat berpikir kritis terhadap masalah-masalah yang muncul sehingga perawat dapat menyesuaikan perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien

Tahap 4: Profesional (*Proficient*): Pada tahap ini, perawat telah mengembangkan intuisi klinis yang kuat dan dapat secara efisien menyesuaikan perawatan untuk setiap situasi yang kompleks. Mereka mampu melihat gambaran besar dari situasi dan memahami implikasi dari tindakan yang mereka ambil. Perawat mulai mengembangkan keterampilan manajerial dan dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah yang kompleks dalam tim perawatan.

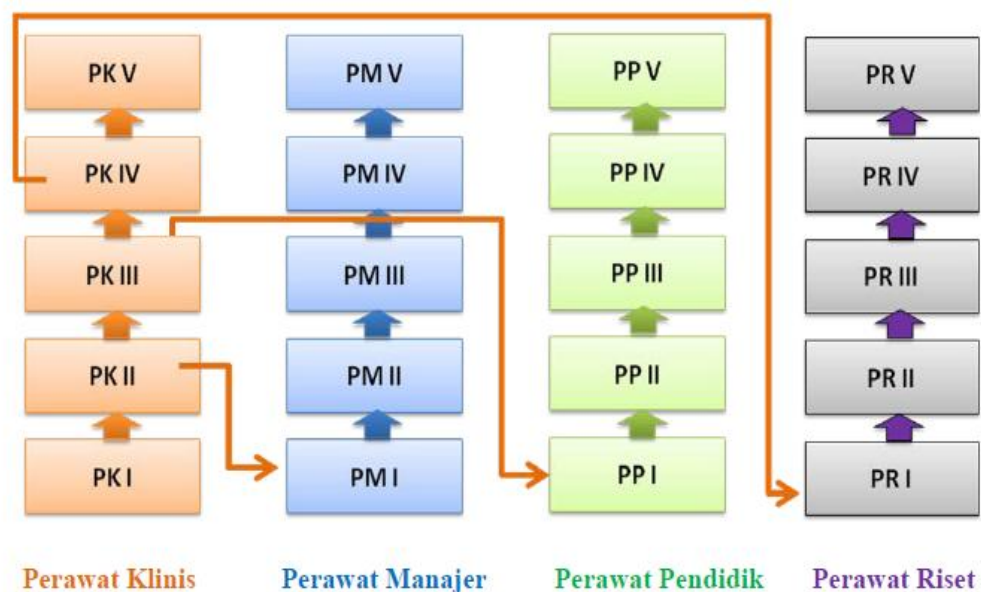
Tahap 5: Ahli (*Expert*): Seorang perawat expert seperti ini memiliki pengalaman yang sangat luas dan dapat dengan mudah menangani situasi yang kompleks tanpa kesulitan berarti. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam, intuisi yang kuat, dan kemampuan untuk secara efektif beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan perawatan kesehatan

Jenjang karir profesional merupakan sistem untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme, sesuai dengan bidang pekerjaan melalui peningkatan kompetensi. Jenjang karir merupakan jalur mobilitas vertikal yang ditempuh melalui peningkatan kompetensi, dimana kompetensi tersebut diperoleh dari pendidikan formal berjenjang, pendidikan informal yang sesuai/relevan maupun pengalaman praktik klinis yang diakui. Dengan arti lain, jenjang karir merupakan jalur untuk peningkatan peran perawat profesional di sebuah institusi. Dalam penerapannya, jenjang karir memiliki kerangka waktu untuk pergerakan dari satu level ke level lain yang lebih tinggi dan dievaluasi berdasarkan penilaian kinerja.

Pengembangan karir profesional perawat mendorong perawat menjadi perawat profesional atau Ners teregister (RN). Perawat profesional diharapkan mampu berpikir rasional, mengakomodasi kondisi lingkungan, mengenal diri sendiri, belajar dari pengalaman dan mempunyai aktualisasi diri sehingga

dapat meningkatkan jenjang karir profesinya. Jenjang karir profesional perawat dapat dicapai melalui pendidikan formal dan pendidikan berkelanjutan berbasis kompetensi serta pengalaman kerja dan kegiatan keprofesionalan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengembangan sistem jenjang karir profesional perawat pada pedoman ini ditujukan bagi perawat klinis yang melakukan praktik sebagai pemberi asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara utuh jenjang karir profesional di Indonesia terdiri dari 4 bidang, meliputi Perawat Klinis (PK), Perawat Manajer (PM), Perawat Pendidik (PP) dan Perawat Peneliti/Riset (PR).



**Gambar 3.2 jenjang karir perawat klinis: Permenkes No.40 tahun 2017**

Setiap bidang memiliki 5 (lima) level, dimulai level generalis, dasar kekhususan, lanjut kekhususan, spesialis, subspesialis/ konsultan. Untuk menjadi perawat manajer level I dipersyaratkan memiliki kompetensi perawat klinis level II. Untuk menjadi perawat pendidik level I dipersyaratkan memiliki kompetensi perawat klinis level III. Untuk menjadi perawat peneliti level I dipersyaratkan memiliki kompetensi perawat klinis level IV.

b. Persyaratan Sistem Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis

Berdasarkan Permenkes no. 40 tahun 2017, Peningkatan ke jenjang karir profesional yang lebih tinggi, perawat klinis harus melalui pengembangan profesional berkelanjutan dan pengakuan terhadap kemampuan yang didasarkan kepada pengalaman kerja dan kinerja praktik keperawatan, serta memenuhi persyaratan tingkat pendidikan, pengalaman kerja klinis keperawatan sesuai area kekhususan serta persyaratan kompetensi yang telah ditentukan.

Peningkatan jenjang karir profesional melalui pengembangan profesional berkelanjutan yang berdasarkan pendidikan dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu pendidikan formal dan pendidikan berkelanjutan berbasis kompetensi (sertifikasi).

Sistem Jenjang Karier Profesional Perawat Klinis merupakan mekanisme strategis untuk menjamin pengembangan kompetensi perawat secara bertahap, objektif, dan berkelanjutan. Penerapan sistem ini mensyaratkan adanya landasan regulasi yang jelas dan komitmen institusi pelayanan kesehatan dalam mengelola sumber daya keperawatan secara profesional. Regulasi tersebut mengacu pada kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Persyaratan utama dalam sistem jenjang karir perawat klinis meliputi kualifikasi pendidikan dan status registrasi yang sah. Perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku serta pendidikan sesuai jenjang profesi, mulai dari lulusan profesi Ners hingga pendidikan lanjutan sesuai kebutuhan layanan. Kualifikasi ini menjadi dasar legitimasi praktik dan penempatan perawat pada level jenjang karir yang tepat.

Selain kualifikasi pendidikan, persyaratan penting lainnya adalah pemenuhan kompetensi klinis yang dibuktikan melalui sertifikat pelatihan, pengalaman kerja, serta hasil penilaian kinerja. Perawat harus menunjukkan kemampuan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai standar praktik, keselamatan pasien, dan etika profesi. Pengalaman klinis yang terukur menjadi indikator kesiapan perawat untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi.

Sistem jenjang karir profesional juga mensyaratkan pelaksanaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) secara konsisten. Perawat diwajibkan mengumpulkan Satuan Kredit Profesi (SKP) melalui berbagai kegiatan pengembangan diri, seperti pelatihan, seminar ilmiah, pendidikan lanjutan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. PPB berfungsi untuk memastikan kompetensi perawat tetap relevan dan mutakhir seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Persyaratan berikutnya adalah adanya mekanisme penilaian dan kredensial yang objektif dan transparan. Institusi pelayanan kesehatan perlu membentuk tim kredensial atau komite keperawatan yang bertugas menilai kompetensi, portofolio, dan kinerja perawat secara periodik. Proses ini menjadi dasar penetapan, pemeliharaan, dan peningkatan jenjang karir perawat klinis.

Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut, sistem jenjang karir profesional perawat klinis dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Implementasi yang konsisten tidak hanya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perawat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan keperawatan di Indonesia.

c. Proses peningkatan jenjang karir (Kredensialing)

Berdasarkan Permenkes No. 40 tahun 2017, Proses kredensialing dalam peningkatan jenjang karir perawat dibagi menjadi 2 skema yaitu skema untuk perawat klinis baru dan perawat lama. Perbedaan kedua skema ini terletak pada proses mapping atau pemetaan. Pemetaan peringkat karir dilaksanakan berdasarkan persyaratan setiap peringkat oleh tim bidang keperawatan untuk menetapkan kelayakan perawat pada level PK sesuai kompetensinya. Pemetaan perangkat karir dinilai berdasarkan pendidikan dan pengalaman asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan, hasil penilaian kinerja klinis dan divalidasi melalui assesmen kompetensi. Setelah asesmen kompetensi perawat memperoleh sertifikat kompetensi sesuai peringkat.

Bagi perawat baru, kredensialing dimulai sejak proses penerimaan dan orientasi kerja. Perawat diwajibkan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai serta Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku. Selanjutnya, perawat baru mengikuti program orientasi dan preceptorship untuk memperkenalkan budaya organisasi, standar pelayanan, serta praktik keperawatan yang aman. Pada tahap ini dilakukan penilaian kompetensi dasar melalui observasi praktik, uji keterampilan klinis, dan evaluasi sikap profesional. Hasil kredensialing menjadi dasar penetapan kewenangan klinis awal dan penempatan perawat pada jenjang karier awal, umumnya sebagai perawat klinis pemula dengan supervisi.

Sementara itu, perawat lama menjalani proses rekredensialing secara berkala untuk memastikan kompetensi tetap terjaga dan berkembang seiring pengalaman kerja. Rekredensialing dilakukan melalui evaluasi portofolio yang mencakup pengalaman klinis, capaian kinerja, sertifikat pelatihan, serta pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) yang dibuktikan dengan Satuan Kredit Profesi (SKP). Penilaian ini juga mempertimbangkan kemampuan perawat dalam menangani kasus yang lebih kompleks, peran sebagai preceptor atau mentor, serta kontribusi dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

## **2. Pengembangan Profesional Berkelanjutan**

a. Definisi pengembangan Profesional Berkelanjutan

Berdasarkan Shinnars and Graebe, (2019) Pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) merupakan pengembangan kompetensi berdasarkan

kepada pendidikan. Perawat yang memiliki pendidikan tinggi dan akan memiliki dampak yang positif terhadap mutu pelayanan kesehatan (Holloway et al., 2018). King et al., (2020) menyatakan PPB merupakan proses partisipasi aktif perawat dalam aktivitas pembelajaran untuk mengembangkan dan menjaga kompetensi secara berkelanjutan, meningkatkan praktek profesional dan mendukung pencapaian tujuan karirnya.

Pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) dan kompetensi merupakan hal yang sangat penting didalam praktek keperawatan.(Bindon & Cne, 2017). Perawat harus memiliki tanggungjawab untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan praktek profesional keperawatan. *The American Nurses Credentialing Center* dalam Bindon and Cne, (2017) menyatakan bahwa kesenjangan merupakan hasil dari perubahan yang disusun untuk memenuhi standar pelayanan, masalah yang ada di area praktek dan kesempatan untuk peningkatan kompetensi. Kesenjangan di area praktek menjadi kebutuhan untuk belajar. Kebutuhan untuk belajar dapat dikategorikan sebagai semua level untuk menjaga kompetensi untuk meningkatkan praktek asuhan keperawatan. Kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan dapat mencakup berbagai pengalaman belajar, dari pembelajaran mandiri kegiatan menulis profesional atau berbicara dengan program pendidikan dan pelatihan formal (Agyepong, 2018).

Program pengembangan profesional berkelanjutan dirancang untuk mempromosikan praktik yang aman, etis, dan kompeten yang berkelanjutan bagi perawat dan memastikan hal itu perawat memiliki peluang untuk pertumbuhan profesional sepanjang karier perawat, untuk berkontribusi untuk perlindungan masyarakat. PPB merupakan komponen kritis dalam pengembangan karir perawat (Price & Reichert, 2017). Pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) meliputi: pengalaman, aktivitas, dan proses yang berkontribusi terhadap perkembangan perawat sebagai tenaga kesehatan profesional. PPB merupakan kegiatan belajar seumur hidup yang meliputi pembelajaran terstruktur (formal) dan informal. Pendidikan berkelanjutan adalah proses belajar sepanjang hayat yang membutuhkan tempat setelah selesainya Pendidikan, pelatihan merupakan komponen penting dari PPB.

Di Indonesia, pengembangan profesional berkelanjutan dituangkan dalam kebijakan PPNI tentang Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) perawat Indonesia adalah proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan perawat dalam kapasitasnya sebagai praktisi, untuk



mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme sebagai perawat sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.

b. Kebijakan Pengembangan Professional Berkelanjutan di Indonesia

Kebijakan Pengembangan professional berkelanjutan di Indonesia di atur dalam Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI No: 094/DPP.PPNI.SK/K.S/IV/2022 tentang Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia di Indonesia. Selain itu Kebijakan tentang PPB di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 tahun 2017. Program PPB disusun sesuai kompetensi pada setiap level karir sesuai dengan jenjang perawat klinis. Jenjang pencapaian PPB perawat disusun sesuai dengan jenjang karir perawatnya, sehingga di masing-masing tahapan karir, program pencapaian PPB akan berbeda. Berdasarkan Permenkes No. 40 tahun 2017, program pengembangan professional berkelanjutan dibagi menjadi setiap level jenjang karir.

PPB pada PK I meliputi asuhan keperawatan: 12 kompetensi inti, komunikasi therapeutik, keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, caring, etika profesi, keperawatan gawat darurat, keperawatan bencana basic, sistem informasi keperawatan. 12 kompetensi pada PK 1 meliputi:

- 1) Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan Keperawatan
- 2) Menerapkan prinsip etika, etiket dalam Keperawatan
- 3) Menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi nosocomial
- 4) Menganalisis, menginterpretasi data dan dokumen secara akurat
- 5) Menciptakan dan melihara lingkungan keperawatan yang amna melalui jaminan kualitas dan manajemen resiko
- 6) Mengukur tanda-tanda vital
- 7) Gunakan tinadakan pencegahan(langkah/tindakan) untuk mencegah cedera pasien/klien
- 8) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan oksigen
- 9) Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit
- 10) Melakukan perawatan luka
- 11) Memberikan obat dengan cara aman dan tepat
- 12) Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman.

Program PPB pada PK II meliputi asuhan keperawatan umum, pengelolaan asuhan keperawatan dalam tim, kerja tim keperawatan, *preceptorship*, Pendidikan Kesehatan, praktik berbasis bukti: diskusi refleksi kasus, metodologi riset dasar (deskriptif dan survey).

Program PPB pada PK III meliputi asuhan keperawatan pada area spesifik, keperawatan gawat darurat intermediate, keperawatan bencana *advance*, keperawatan kritis basic, pengelolaan asuhan keperawatan di ruangan, menerapkana agen pembaharu terkait asuhan melalui *evidence based practice*, audit asuhan keperawatan, metode mencari akar masalah (RCA), manajemen resiko terkait asuhan keperawatan, manajemen konflik, kolaborasi intra dan interdisiplin, menyusun satuan pengajaran Pendidikan Kesehatan, metodologi riset lanjutan (analitik dan differensial).

Program PPB pada PK IV meliputi asuhan keperawatan spesialistik, keperawatan gawatdarita advance, keperawatan kritis advance, keperawatan klinis advance, keterampilan klinis spesialis, case manajer, metodologi Pendidikan kesehatan, sasaran kelompok/masyarakat dan klien denan masalah kesehatan kompleks, *failure mode and effect analysis* (FMEA), Praktik berbasis bukti lanjutkan, Teknik penyusunan jurnal.

Program PPB pada PK V meliputi asuhan keperawatan sub spesialis, keterampilan klinis sub spesialis, manajemen asuhan keperawatan di RS, manajemen strategik asuhan keperawatan, manajemen konseling, metodologi Pendidikan Kesehatan sasaran kelompok/masyarakat dan klien dengan masalah kesehatan kompleks, metodologi riset *clinical trial*, eksperimen, kuasi eksperimen.

c. Tujuan PPB perawat Indonesia

Berdasarkan PPNI tahun 2022 tujuan Pengembangan Profesional Berkelanjutan di Indonesia adalah meningkatkan kompetensi professional setiap perawat sesuai dengan perkembangan ilmu pngetahuan dan teknologi di bidang kesehatan khususnya keperawatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, tuntutan profesi agar dapat meningkatkan mutu pleyanan keperawatan sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi dan standar kode etik keperawatan Indonesia.

Adapun tujuan PPB Perawat Indonesia yaitu:

- 1) Memelihara dan meningkatkan kemampuan profesioanl perawat sesuai standar kompetensi dan standar kode etik keperawatan Indonesia
- 2) Terjaminnya mutu pelayanan keperawatan melalui upaya pengembangan kompetensi profesional secara berkelanjutan

d. Prinsip PPB Perawat Indonesia

Prinsip PPB perawat Indonesia sebagai berikut:

- 1) Setiap perawat harus mempunyai rencana pengembangan diri sebagai upaya peningkatan mutu dan kompetensi dan rencana pengembangan diri dilakukan dengan menngisi formulir evaluasi diri

- 2) Merupakan kegiatan mandiri (*self directed*) dalam menjalankan praktik keperawatan (*practice based*)
- 3) Merupakan upaya meningkatkan kompetensi, digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari PPNI dalam rangka re-registrasi STR
- 4) Memberikan motivasi, memberikan pelayanan terbaik bagi klien, memenuhi kewajiban sesuai standar profesi, mendapatkan kepuasan diri, dan mengembangkan diri dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan jenjang karier profesi.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian PPB

Pendidikan dan pelatihan merupakan dua komponen dalam pengembangan staf (Marquis & Huston, 2015). Pendidikan merupakan upaya formal dan lebih luas cakupannya daripada pelatihan. Mengetahui kebutuhan pendidikan dan memotivasi staf untuk dapat melanjutkan pendidikan merupakan tugas dan tanggungjawab pimpinan. Pelatihan dilakukan untuk memberikan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kompetensi secara afektif, motorik dan kognitif. Peningkatan ketrampilan akan meningkatkan produktivitas dan kinerja staf (Daphney et al., 2020).

Menurut Vasli, Dehghan-Nayeri and Khosravi, (2018), faktor-faktor yang mendukung pencapaian PPB adalah

- 1) Struktur dan iklim organisasi kondusif diharapkan mampu meningkatkan komitmen perawat pada pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, terhadap rekan sekerja dalam kelompok kerja, maupun organisasi secara umum. Kondisi struktur dan iklim organisasi bisa meliputi sarana fisik maupun non fisik.
- 2) Karakteristik individu meliputi bagaimana persepsi individu, efikasi diri dan motivasi individu dalam mencapai PPBnya.
- 3) Kualifikasi profesional, Perawat harus termotivasi untuk mengambil bagian dalam proses Pendidikan keperawatan.
- 4) Program Pendidikan, dibutuhkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perawat. Hasil penelitian Hariyati et al., (2017) menyatakan PPB dapat meningkatkan kompetensi, keselamatan pasien, dan meningkatkan profesionalisme perawat.

Menurut Oyetunde & Oluwafunke, (2015) terdapat tiga fase dalam pengembangan profesional berkelanjutan, meliputi:

- 1) Pendidikan keperawatan. Pendidikan keperawatan merupakan pilar penting dalam pencapaian PPB. Elaborasi antara pendidikan dengan professionalism keperawatan merupakan suatu hubungan timbal balik.

- 2) Jenjang karir keperawatan, dapat mengembangkan kompetensi, kemampuan berfikir kritis, dan tahapan pencapaian karir sesuai dengan jenjang pendidikan dan pengalaman.
- 3) Pengembangan professional berkelanjutan, merupakan fase dimana perawat memiliki keberagaman kompetensi dan kemampuan di area kerja. Keberagaman kompetensi menunjukkan karir yang sudah sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. Program pengembangan karir mengintegrasikan pendidikan, sertifikasi, peningkatan tanggungjawab dan kewenangan perawat.

Aktivitas pencapaian PPB meliputi: a) belajar secara formal maupun informal dengan melanjutkan pendidikan, ataupun mengikuti seminar/kursus-kursus, b) belajar dari pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan akan meningkat sesuai dengan pengalaman dalam melaksanakan, c) belajar dari interaksi sosial dengan rekan kerja, belajar dengan rekan sejawat, dan tenaga kesehatan lain dapat meningkatkan pengetahuan, konsultasi dan umpan balik terhadap kompetensi yang dilakukan, d) belajar dari media seperti buku, internet, artikel dan SOP.

Bentuk kegiatan PKB perawat Indonesia meliputi:

1) Kegiatan Praktek Profesional

Kegiatan praktek professional merupakan pemberian pelayanan keperawatan terdiri dari: (a) pemberian asuhan keperawatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan/praktek mandiri, (b) pembimbingan praktek mahasiswa di klinik/masyarakat, (c) pengelolaan pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan

2) Kegiatan Ilmiah meliputi: seminar atau *conference*, workshop atau lokakarya, Pelatihan, kegiatan oragnisasi PPNI.

3) Kegiatan Pengembangan Ilmu pengetahuan, merupakan kegiatan:

- a) Penelitian terpublikasi local, nasional, dan internasional serta mendapatkan hak paten dan Hak kekayaan intelektual (HaKI)
- b) Presentasi oral/poster tingkat nasional/internasional
- c) Karya ilmiah (penulisan jurnal, artikel, penerjemah dan penyunting buku

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan: aktif dalam kegiatan dan pengembangan profesi, bekerja di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan, sebagai pengurus PPNI, badan kelengkapan dan badan-badan lain yang diakui oleh PPNI selama periode menjabat, tim tanggap bencana, penugasan pemerintah, pimpinan Lembaga pemerintah, mendapatkan penghargaan dan prestasi kerja

f. Komponen Pengembangan Professional Berkelanjutan

Berdasarkan Mlambo et al., (2021) komponen PPB terdiri dari:

1) Budaya Organisasi

Budaya organisasi memegang peranan penting dalam pengembangan professional berkelanjutan staf. Komitmen organisasi dan dukungan kepada pengembangan professional staf menunjukkan bahwa staf dihargai dalam suatu organisasi. Budaya organisasi dalam menyiapkan fasilitas pendanaan untuk program PPB, memberikan akses staf dalam pembelajaran PPB, adanya peran manajemen dalam pengembangan professional berkelanjutan staf, beban kerja staf keperawatan, desain dan penyampaian PPB, adanya komunikasi dan kolaborasi antara lembaga penyelenggara PPB dan manajemen RS akan memberikan budaya organisasi yang baik dalam mendukung pengembangan professional staf.

2) Dukungan Lingkungan

Lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran merupakan salah satu prasyarat yang diperlukan dalam PPB. Kondisi tersebut harus mencakup pemberian tugas yang fleksibel untuk memberikan waktu staf untuk belajar, ketersediaan sarana belajar di tempat kerja, beban kerja tidak berlebihan dan adanya dukungan dana untuk melaksanakan PPB bagi staf.

3) Sikap dan Motivasi Perawat

Sikap perawat terhadap PPB yang menyatakan bahwa PPB penting untuk mendapatkan dan mempertahankan lisensi, dan merasa bahwa tanggung jawab untuk mendaftar dan berpartisipasi dalam kegiatan CPD adalah dengan individual perawat, bukan dengan organisasi yang mempekerjakan staf merupakan sikap dan persepsi yang harus dibenahi. Perawat harus merasa lebih termotivasi untuk belajar jika mereka dapat dengan mudah mengakses program PPB, jika perawat merasa didukung, dan ditawarkan untuk ikut serta dalam kegiatan PPB. Pembelajaran dengan metode bedside teaching dan pelatihan-pelatihan secara informal merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Berdasarkan Vázquez-Calatayud et al., (2021), perawat percaya bahwa CPD dapat membantu kebutuhan perawat terhadap pekerjaannya. PPB memberikan kepercayaan diri dalam diri perawat untuk dapat bekerja multidisiplin dengan profesi lain.

4) Persepsi Perawat Terhadap Hambatan PPB

Jumlah perawat yang kurang, beban kerja yang tinggi dan kurangnya waktu untuk belajar merupakan sikap yang dipersepsikan perawat dalam hambatan dalam menerima pembelajaran. Hambatan dalam PPB meliputi

area PPB yang jauh dari area klinis, adanya ketidaksesuaian antara harapan dan hasil yang dicapai

### **C. Simpulan**

---

Jenjang karier perawat dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB) merupakan dua pilar utama dalam penguatan kompetensi perawat di Indonesia. Jenjang karier memberikan arah pengembangan profesional yang jelas dan sistematis melalui jalur klinis, manajerial, akademik, dan spesialis. Melalui sistem ini, perawat berkembang secara bertahap berdasarkan pengalaman kerja, pendidikan, serta kompetensi yang dimiliki, sehingga mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar praktik profesional.

Penerapan jenjang karier perawat yang terstruktur berkontribusi pada peningkatan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja perawat. Selain itu, sistem ini mendorong praktik keperawatan berbasis kompetensi dan keselamatan pasien, serta memperkuat akuntabilitas profesional perawat dalam pelayanan kesehatan. Kebijakan jenjang karier juga menjadi instrumen penting dalam manajemen sumber daya keperawatan untuk menjamin pemerataan kompetensi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) berperan dalam menjaga dan meningkatkan kompetensi perawat seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompleksitas kebutuhan pelayanan kesehatan. PPB dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, seminar ilmiah, pendidikan formal lanjutan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan menjadi bagian dari kewajiban profesional perawat dalam mempertahankan legitimasi praktik keperawatan.

Integrasi antara jenjang karier dan PPB memperkuat pengembangan kompetensi perawat secara berkelanjutan dan terarah. PPB yang dikaitkan dengan jenjang karier mendorong peningkatan kapasitas klinis, manajerial, dan profesional perawat sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan kualitas individu perawat, tetapi juga berdampak positif pada mutu asuhan keperawatan, keselamatan pasien, serta kinerja organisasi pelayanan kesehatan. Penguatan jenjang karier dan pendidikan profesional berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta institusi pelayanan dan pendidikan keperawatan. Dengan penerapan yang terintegrasi dan berkesinambungan, jenjang karier dan PPB menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perawat Indonesia yang kompeten, profesional, dan mampu menjawab tantangan sistem kesehatan nasional.

## D. Referensi

---

- Agyepong, E. B. (n.d.). *Analysis of the Concept Continuing Education in Nursing Education*. 5(1), 96–107.
- Bindon, S. L., & Cne, D. N. P. R. (2017). Professional Development Strategies to Enhance Nurses' Knowledge and Maintain Safe Practice. *AORN Journal*, 106(2), 99–110. <https://doi.org/10.1016/j.aorn.2017.06.002>
- Daphney, S.-G., Lynda, B., Valérie, C., & Caroline, G. (2020). The INSÉPARable portfolio tool to sustain continued education and the professional development of nurses for a full scope of nursing practice and enhanced patient safety competencies: An ethnographic study. *International Journal of Nursing Studies Advances*, 2(October), 100011. <https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2020.100011>
- Holloway, K., Arcus, K., & Orsborn, G. (2018). Nurse Education in Practice Training needs analysis e The essential first step for continuing professional development design. *Nurse Education in Practice*, 28, 7–12. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.09.001>
- King, R., Taylor, B., Talpur, A., Jackson, C., Manley, K., Ashby, N., Tod, A., Ryan, T., Wood, E., Senek, M., & Robertson, S. (2020). Factors that optimise the impact of continuing professional development in nursing: A rapid evidence review. *Nurse Education Today*, 98(October), 104652. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104652>
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (n.d.). *No Title*.
- Mlambo, M., Silén, C., & McGrath, C. (2021). Lifelong learning and nurses' continuing professional development, a metasynthesis of the literature. *BMC Nursing*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00579-2>
- Oyetunde, M. O., & Oluwafunke, K. I. (2015). *Professional Development and Career Pathway in Nursing*.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis
- Price, S., & Reichert, C. (2017). *administrative sciences The Importance of Continuing Professional Development to Career Satisfaction and Patient Care : Meeting the Needs of Novice to Mid- to Late-Career Nurses throughout Their Career Span*. 41–52. <https://doi.org/10.3390/admsci7020017>
- Scharton, K., & Benner, P. (2013). *Reforming Nurses: Historicizing the Carnegie*

*Foundation 's Report on Educating Nurses. 21, 97–108.*

- Shinners, J., & Graebe, J. (2019). Continuing professional development: Utilizing competency-based education and the american nurses credentialing center outcome-based continuing education model. *Journal of Continuing Education in Nursing, 50*(3), 100–102. <https://doi.org/10.3928/00220124-20190218-02>
- Tutik, R., Hariyati, S., & Fujinami, Y. (2017). *Correlation between Career Ladder , Continuing Professional Development and Nurse Satisfaction : A Case Study in Indonesia. 10*(3), 1490–1497.
- Vasli, P., Dehghan-Nayeri, N., & Khosravi, L. (2018). Factors affecting knowledge transfer from continuing professional education to clinical practice: Development and psychometric properties of a new instrument. *Nurse Education in Practice, 28*(January 2016), 189–195. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.10.032>
- Vázquez-Calatayud, M., Errasti-Ibarrondo, B., & Choperena, A. (2021). Nurses' continuing professional development: A systematic literature review. *Nurse Education in Practice, 50*(July 2020), 102963. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102963>

## **E. Glosarium**

---

PPB: Pengembangan Profesional Berkelanjutan





# CHAPTER 4

## PENGUATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME TENAGA KESEHATAN DI ERA MODERN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KESEHATAN

Dra. Wiwin Winarti, S.S., M.I.Kom.

### A. Pendahuluan / Prolog

Pada Desember 2025, dalam sebuah postingan *Instagram* dari pemilik akun *@moucup* dengan pemilik akun Cicilia Tanujaya menulis sebuah tagar *#kitabershaktaudok*. Postingan ini berawal saat ayah pemilik akun meninggal dunia di sebuah rumah sakit "B" setelah sebelumnya sang ayah dirawat di rumah sakit "A". Dalam postingannya sang ayah mulanya menderita sakit flu dan batuk dan dibawa dokter keluarga yaitu dokter "H", Oleh dokter "H" kemudian dirujuk ke rumah sakit "A". Selama dirawat di rumah sakit "A" sang ayah merasa sakitnya tidak berkurang dan meminta pemeriksaan lanjut. Namun pihak rumah sakit mengabaikan permintaan tersebut. Alih-alih diperiksa, pasien malah dinyatakan kondisinya membaik dan boleh pulang. Karena sang ayah masih merasa sakit, maka keluarga memilih untuk mendapatkan *second opinion* dan membawanya ke rumah sakit "B". Di rumah sakit "B" sang ayah di test ulang secara menyeluruh dan ternyata ditemukan fakta bahwa dari hasil test laboratorium kondisi sang ayah tidak baik-baik saja dan malahan terindikasi mengalami perburukan. Pada hari kedua sang ayah meninggal dunia. Keluarga pasien tidak terima dan menuntut penjelasan dari dokter "H" dan rumah sakit "A", mengapa mereka sangat abai atas kondisi pasien dan abai pada permintaan keluarga untuk melakukan pemeriksaan ulang. Hingga buku ini ditulis, status terakhir dari akun *@moucup* adalah dokter "H" telah meminta maaf kepada pihak keluarga dan mengakui kelalaian dari penanganan pasien. Permintaan maaf telah diterima oleh pihak keluarga. Dengan demikian permasalahan antara kedua pihak dianggap selesai.

Tidak satupun keluarga atau rumah sakit atau dokter ingin mengalami kejadian seperti diatas. Rumah sakit adalah tempat dimana semua orang berharap kesembuhan dan pelayanan Kesehatan. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan kesehatan sebagai hak asasi manusia, menjamin akses layanan kesehatan yang aman dan terjangkau, mengatur sumber daya kesehatan,

upaya kesehatan, tenaga kesehatan, sediaan farmasi, hingga pembiayaan kesehatan. Salah satu poin penting dari undang-undang tersebut adalah hak atas Kesehatan, dimana setiap orang berhak atas akses sumber daya kesehatan, pelayanan aman, bermutu, terjangkau, lingkungan sehat, serta informasi kesehatan.

Dunia medis semakin berkembang. Perkembangan sistem pelayanan kesehatan di era modern menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kompetensi profesional yang mencakup aspek komunikasi, etika, dan pemahaman hukum kesehatan (Beauchamp & Childress, 2013; World Health Organization, 2016). Pasien tidak lagi diposisikan sebagai objek pelayanan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang memadai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait tindakan medis yang akan diterimanya. Kondisi ini menempatkan *informed consent* sebagai salah satu indikator penting profesionalisme tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan. Dari penelitian (Winarti Wiwin et al., 2025) seorang dokter bedah umum yang melakukan pembedahan menyatakan bahwa informed consent merupakan bentuk edukasi dari seorang dokter kepada pasien. Tenaga kesehatan (dokter, perawat, dsb) harus mampu menerjemahkan terminologi kedokteran dan menyampaikannya kepada pasien dengan bahasa yang mudah dimengerti. Pasien harus benar-benar paham atas diagnosis pemeriksaan sesuai yang disarankan, langkah-langkah yang harus dilakukan dan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan bila ada. Dokter lain yaitu dokter bedah ortopedi menggunakan alat peraga seperti *phantom* tulang kerangka saat menerangkan kondisi masalah yang dihadapi pasiennya, sehingga pasien mendapatkan gambaran tentang kondisinya yang sebelumnya abstrak dan mengetahui konsekuensi tindakan yang akan dilakukan. Keterbukaan informasi seperti ini harus dilakukan sehingga tidak akan terjadi penuntutan di kemudian hari bila ada kejadian yang tidak diinginkan.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, praktik informed consent menjadi semakin kompleks karena diterapkan tidak hanya pada pelayanan klinis individual, tetapi juga dalam berbagai program kesehatan yang melibatkan populasi luas, seperti program operasi elektif, pelayanan rujukan, skrining kesehatan, serta tindakan medis dalam program promotif dan preventif. Prinsip ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan , 2023) yang menempatkan hak pasien atas informasi dan persetujuan sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Kualitas pelaksanaan informed consent sangat ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan, khususnya dalam menyampaikan informasi secara jelas, jujur, dan mudah

dipahami oleh pasien dengan latar belakang sosial, budaya, dan tingkat literasi kesehatan yang beragam.

Informed consent adalah persetujuan sukarela dari pasien (keluarga/atau wakilnya) untuk tindakan medis, setelah mendapatkan penjelasan lengkap dari dokter tentang diagnosis, prosedur, risiko, manfaat, dan alternatifnya, sehingga pasien bisa membuat keputusan sendiri tanpa paksaan. Ini adalah proses penting yang memastikan otonomi pasien dan melindungi hukum dokter, bukan sekadar tanda tangan, melainkan pemahaman mendalam dan keputusan sadar. Dalam (Beauchamp & Childress, 2013) diuraikan elemen-elemen utama informed consent adalah sebagai berikut:

- 1. Informasi:** Dokter harus menjelaskan secara rinci mengenai diagnosis, rencana tindakan, cara kerja, efek samping, risiko, manfaat, prognosis, dan pilihan terapi lain.
- 2. Pemahaman:** Pasien harus memahami informasi yang diberikan dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai tingkat pendidikannya.
- 3. Kesukarelaan (Voluntariness):** Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan, mencerminkan kehendak bebas pasien.
- 4. Kompetensi:** Pasien harus mampu membuat keputusan, atau jika tidak, persetujuan diberikan oleh wali/keluarga terdekat.
- 5. Kapan diperlukan:** Semua tindakan medis yang direncanakan, diagnostik, atau terapeutik, seperti operasi, pengobatan, atau prosedur khusus.
- 6. Pengecualian:** Situasi gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan, di mana tindakan dapat dilakukan sebelum *informed consent*.
- 7. Bentuk:** Lisan, tertulis, atau tersirat (implied consent) dalam kasus rutin seperti pemeriksaan awal di poliklinik.

## **B. Kompetensi Tenaga Kesehatan dalam Praktik Informed Consent**

---

Kompetensi tenaga kesehatan dalam praktik informed consent tidak dapat dipisahkan dari kemampuan komunikasi kesehatan yang efektif (Schenker et al., 2011; Street et al., 2009). Dalam konteks Indonesia, kewajiban pelaksanaan informed consent secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang menegaskan bahwa persetujuan harus diberikan setelah pasien memperoleh penjelasan yang cukup mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Tenaga kesehatan dituntut untuk mampu menjelaskan diagnosis, tujuan tindakan, prosedur, risiko, manfaat, serta alternatif tindakan dengan bahasa yang dapat dipahami pasien. Selain kompetensi komunikasi, pemahaman terhadap aspek etika dan

hukum kesehatan juga menjadi prasyarat utama agar informed consent tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan persetujuan yang diberikan secara sadar dan sukarela oleh pasien.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, kompetensi ini menjadi krusial karena tenaga kesehatan sering berhadapan dengan pasien atau kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan medis. Ketidakseimbangan informasi antara tenaga kesehatan dan pasien berpotensi menimbulkan relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga persetujuan yang diberikan pasien berisiko bersifat semu. Oleh karena itu, profesionalisme tenaga kesehatan tercermin dari kemampuannya menjembatani kesenjangan informasi tersebut melalui komunikasi yang empatik dan partisipatif.

### **C. Refleksi Empiris dari Praktik Informed Consent Tenaga Kesehatan**

---

Temuan empiris dari penelitian sebelumnya mengenai praktik informed consent pada dokter bedah menunjukkan bahwa pelaksanaan informed consent sering kali masih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, sebagaimana juga dilaporkan dalam berbagai studi internasional mengenai praktik persetujuan tindakan medis (Hall et al., 2012; Kunneman et al., 2014). Pasien pada umumnya telah menandatangani formulir persetujuan tindakan medis, namun belum sepenuhnya memahami informasi yang disampaikan terkait risiko, manfaat, maupun alternatif tindakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep ideal informed consent dan praktik di lapangan.

Disisi lain Deddy Mulyana dkk. (2022) menegaskan bahwa cara berkomunikasi antara praktisi medis dan pasien sering kali tidak hanya berbeda dalam pemahaman mengenai penyakit, penyebab, dan pilihan terapi, tetapi juga dalam pola komunikasi verbal dan nonverbal. Ketika salah satu pihak tidak mampu beradaptasi dalam interaksi komunikasi, potensi terjadinya kesalahpahaman menjadi semakin besar. Dalam konteks ini, tenaga medis dan pasien dapat dipandang sebagai dua kelompok sosial yang memiliki sistem komunikasi, nilai, dan cara memaknai pesan yang berbeda.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa, dan sistem nilai, serta masih kuatnya pola hubungan paternalistik dalam pelayanan kesehatan. Mulyana dkk. (Mulyana Deddy & Rachmawati Devie, 2022) menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, peran komunikasi terapeutik justru menjadi lebih krusial dibandingkan dengan negara-negara Barat yang lebih liberal. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian tenaga medis masih memandang pasien sebagai objek pasif pelayanan, sementara pasien sendiri kerap enggan mengajukan pertanyaan karena

merasa memiliki posisi sosial yang lebih rendah. Situasi ini berpotensi menghambat proses reduksi ketidakpastian pasien, terutama ketika waktu konsultasi terbatas.

Meskipun penelitian sebelumnya berfokus pada pelayanan bedah yang bersifat klinis dan teknis, temuan ini relevan untuk direfleksikan dalam konteks kesehatan masyarakat. Jika pada pelayanan bedah yang memiliki standar prosedur ketat masih ditemukan permasalahan dalam kualitas informed consent, maka dalam program kesehatan masyarakat yang melibatkan interaksi massal dan keterbatasan waktu pelayanan, tantangan serupa bahkan berpotensi lebih besar. Dengan demikian, praktik informed consent dapat digunakan sebagai cerminan tingkat kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan secara lebih luas.

#### **D. Hambatan dalam Implementasi Informed Consent pada Program Kesehatan**

---

Berbagai hambatan memengaruhi optimalisasi praktik informed consent dalam program kesehatan, baik pada level sistem maupun individu tenaga Kesehatan (Elwyn et al., 2012; World Health Organization, 2017). Hambatan struktural seperti keterbatasan waktu pelayanan, beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi, serta target capaian program sering kali menyebabkan proses komunikasi dengan pasien menjadi singkat dan tidak mendalam. Selain itu, perbedaan latar belakang sosial budaya dan tingkat literasi kesehatan masyarakat juga mempersulit proses penyampaian informasi secara efektif.

##### **1. Hambatan Keterbatasan Waktu**

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan informed consent yang berkualitas adalah keterbatasan waktu pelayanan, terutama pada fasilitas kesehatan dengan jumlah kunjungan pasien yang tinggi. Dalam praktik pelayanan kesehatan masyarakat, dokter sering dihadapkan pada antrian pasien yang panjang, beban kerja yang berat, serta tuntutan efisiensi layanan. Kondisi ini berpotensi membatasi durasi interaksi dokter–pasien, sehingga proses penyampaian informasi medis tidak selalu berlangsung secara optimal. Akibatnya, informed consent berisiko direduksi menjadi proses administratif semata, tanpa didahului oleh komunikasi yang memadai untuk memastikan pemahaman pasien.

Dalam kerangka Uncertainty Reduction Theory, keterbatasan waktu menjadi faktor penghambat utama dalam upaya menurunkan ketidakpastian pasien. Waktu komunikasi yang singkat dapat mengurangi kesempatan pasien untuk mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi informasi, serta membangun rasa percaya terhadap tenaga kesehatan. Ketika ketidakpastian tidak terkelola dengan baik, pasien cenderung merasa tidak puas dan kurang yakin terhadap keputusan

medis yang diambil, meskipun secara formal telah menandatangani persetujuan tindakan medis.

Namun demikian, keterbatasan waktu tidak selalu harus berbanding lurus dengan rendahnya kualitas informed consent. Efisiensi komunikasi dapat dicapai melalui strategi pengelolaan komunikasi yang terencana dan terstruktur. Dalam perspektif Social Penetration Theory, kedalaman komunikasi tidak harus dicapai melalui durasi interaksi yang panjang, melainkan melalui penentuan lapisan informasi yang paling relevan bagi pasien. Penyampaian informasi yang fokus, terarah, dan disesuaikan dengan karakter pasien memungkinkan proses penetrasi sosial berlangsung lebih cepat tanpa mengorbankan pemahaman.

Selain itu, pendekatan komunikasi yang adaptif terhadap karakter dan kebutuhan pasien berperan penting dalam mengoptimalkan waktu. Dengan mengenali kecenderungan karakter pasien, tenaga kesehatan dapat memilih gaya penyampaian yang paling efektif sejak awal interaksi, sehingga proses edukasi menjadi lebih efisien. Strategi ini membantu meminimalkan pengulangan penjelasan dan mengurangi kesalahpahaman yang justru memakan waktu lebih panjang di kemudian hari.

Pada tingkat sistem pelayanan kesehatan masyarakat, optimalisasi informed consent di tengah keterbatasan waktu juga dapat didukung melalui pemanfaatan media edukasi pendukung, seperti lembar informasi tertulis, infografik, atau media audiovisual yang mudah dipahami. Media tersebut berfungsi sebagai pelengkap komunikasi lisan, sehingga pasien telah memperoleh gambaran awal sebelum atau sesudah konsultasi singkat dengan dokter. Dengan demikian, komunikasi tatap muka dapat difokuskan pada klarifikasi informasi utama dan pengambilan keputusan, bukan pada penjelasan dasar yang berulang.

Dengan pendekatan ini, informed consent tetap dapat disampaikan secara komprehensif tanpa menambah beban waktu pelayanan secara signifikan. Upaya ini sejalan dengan prinsip pelayanan kesehatan masyarakat yang menekankan efisiensi, keadilan akses, dan kepuasan pasien, sekaligus memastikan bahwa hak pasien atas informasi tetap terpenuhi secara etis dan profesional.

## **2. Hambatan Perbedaan Latar Belakang Sosial Budaya Dan Tingkat Literasi Kesehatan**

Hambatan lainnya berasal dari aspek kompetensi tenaga kesehatan, khususnya dalam keterampilan komunikasi interpersonal dan pemahaman hukum kesehatan. Tidak semua tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan khusus terkait komunikasi risiko dan pengambilan keputusan bersama (shared decision making) (Elwyn et al., 2012). Akibatnya, informed consent cenderung dipahami

sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai proses komunikasi yang berkelanjutan antara tenaga kesehatan dan pasien.

Dalam perspektif Uncertainty Reduction Theory, perbedaan pola komunikasi dan relasi kuasa yang timpang dapat memperbesar ketidakpastian pasien, karena informasi yang dibutuhkan tidak sepenuhnya tersampaikan atau dipahami. Keterbatasan waktu pelayanan semakin memperkuat hambatan ini, karena tenaga kesehatan sering kali tidak memiliki cukup ruang untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan latar belakang budaya dan karakter pasien. Akibatnya, informed consent memang dapat tersampaikan secara formal, tetapi belum tentu dipahami secara substantif oleh pasien.

Lebih lanjut, dari sudut pandang Social Penetration Theory, perbedaan budaya dan gaya komunikasi memengaruhi kecepatan serta kedalaman penetrasi komunikasi dalam relasi dokter–pasien. Dalam konteks kesehatan masyarakat, penetrasi komunikasi yang efektif tidak menuntut interaksi yang panjang, tetapi memerlukan sensitivitas terhadap makna verbal dan nonverbal pasien yang bersifat kultural. Mulyana dkk. (Mulyana Deddy & Rachmawati Devie, 2022) menekankan pentingnya kompetensi interkultural tenaga kesehatan, yaitu kemampuan untuk mengenali cara pasien memahami penyakit dan pengalaman sakitnya, serta menghargai makna-makna tersebut meskipun berada di luar kerangka biomedis murni.

Dengan demikian, upaya mengatasi hambatan keterbatasan waktu dalam informed consent tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kompetensi komunikasi terapeutik dan interkultural tenaga kesehatan. Adaptasi komunikasi yang sensitif terhadap budaya, karakter, dan pengalaman sakit pasien memungkinkan proses reduksi ketidakpastian dan penetrasi komunikasi berlangsung lebih efisien, tanpa harus memperpanjang durasi interaksi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pelayanan kesehatan masyarakat yang menekankan efisiensi layanan sekaligus perlindungan hak pasien atas informasi yang utuh dan bermakna.

## **E. Implikasi bagi Penguatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Masyarakat**

---

Berdasarkan refleksi empiris dan analisis hambatan tersebut, penguatan kompetensi tenaga kesehatan masyarakat perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan komunikasi kesehatan yang berorientasi pada pasien. Pelatihan informed consent sebaiknya tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan komunikasi empatik, sensitif budaya, dan berbasis kebutuhan masyarakat.



Meskipun tenaga kesehatan secara rutin mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kompetensi, pelatihan khusus yang berfokus pada keterampilan komunikasi—terutama dalam konteks penyampaian informed consent—masih kerap dipandang sebagai kebutuhan sekunder. Fenomena ini tidak terlepas dari dominannya paradigma biomedis dalam sistem pelayanan kesehatan, yang menempatkan keterampilan teknis dan klinis sebagai indikator utama profesionalisme tenaga kesehatan. Dalam kerangka tersebut, komunikasi sering dipersepsikan sebagai kemampuan alamiah yang akan berkembang seiring pengalaman praktik, bukan sebagai kompetensi profesional yang perlu dilatih secara sistematis.

Selain itu, tekanan beban kerja, keterbatasan waktu pelayanan, serta tuntutan efisiensi sistem turut memengaruhi prioritas pelatihan yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Pelatihan komunikasi sering dianggap tidak memberikan dampak langsung terhadap indikator kinerja klinis, seperti kecepatan pelayanan atau capaian prosedural, sehingga kurang mendapat perhatian dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Akibatnya, komunikasi—termasuk dalam penyampaian informed consent—cenderung direduksi menjadi aktivitas pelengkap, bukan bagian integral dari proses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Walaupun komunikasi tidak dimaksudkan sebagai panacea yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan pelayanan kesehatan, namun pendekatan komunikasi yang tepat dapat berfungsi sebagai jalan keluar non-medis untuk mengatasi sejumlah permasalahan, seperti ketidakpahaman pasien, rendahnya kepatuhan terhadap rencana terapi, ketidakpuasan layanan, serta potensi konflik antara tenaga kesehatan dan pasien. Dalam konteks informed consent, komunikasi yang efektif berperan penting dalam mengelola ekspektasi pasien, menurunkan ketidakpastian, serta membangun kepercayaan, tanpa harus menambah intervensi klinis atau biaya tambahan.

Dari perspektif Uncertainty Reduction Theory, kegagalan dalam memberikan pelatihan komunikasi yang memadai justru berpotensi memperbesar ketidakpastian pasien, meskipun tindakan medis telah dilakukan sesuai standar. Sementara itu, Social Penetration Theory menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi membantu tenaga kesehatan menentukan kedalaman interaksi yang tepat dalam waktu yang terbatas, sehingga informasi penting dapat tersampaikan secara efektif tanpa melanggar batas profesional. Dengan kata lain, komunikasi bukanlah pengganti kompetensi medis, melainkan pelengkap strategis yang memperkuat efektivitas intervensi klinis.

Oleh karena itu, penguatan pelatihan komunikasi, khususnya dalam penyampaian informed consent, perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Pelatihan semacam ini tidak bertujuan menjadikan tenaga kesehatan sebagai komunikator semata, tetapi membekali mereka dengan keterampilan adaptif untuk menghadapi keragaman karakter, budaya, dan kebutuhan pasien. Pendekatan non-medis melalui komunikasi yang terstruktur dan sensitif terhadap konteks sosial ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan, kepuasan pasien, serta keberlanjutan hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

Pelatihan komunikasi dalam penyampaian informed consent tidak harus diwujudkan dalam bentuk pelatihan intensif yang memakan waktu lama atau biaya besar. Pendekatan yang lebih realistis justru dapat dilakukan melalui integrasi keterampilan komunikasi ke dalam aktivitas rutin pelayanan kesehatan. Salah satu contoh konkret adalah pelatihan singkat berbasis studi kasus, di mana tenaga kesehatan mendiskusikan skenario nyata interaksi dokter–pasien yang sering menimbulkan kesalahpahaman, termasuk kasus keterbatasan waktu, perbedaan karakter pasien, dan hambatan budaya. Diskusi ini dapat dilakukan dalam waktu singkat, misalnya 30–60 menit, sebagai bagian dari kegiatan rutin seperti rapat klinis atau pertemuan staf.

Pendekatan lain yang relatif mudah diterapkan adalah simulasi komunikasi singkat (micro role-play) yang berfokus pada tahap awal informed consent. Dalam simulasi ini, tenaga kesehatan dilatih untuk menyampaikan informasi inti secara ringkas, jelas, dan adaptif terhadap karakter pasien, tanpa harus melakukan simulasi klinis yang kompleks. Fokus pelatihan bukan pada akurasi medis, melainkan pada pemilihan bahasa, struktur penjelasan, dan respons terhadap pertanyaan pasien. Model ini memungkinkan tenaga kesehatan mengasah keterampilan komunikasi secara praktis dalam waktu terbatas.

Selain itu, pelatihan komunikasi juga dapat dikembangkan melalui refleksi pengalaman praktik (reflective learning). Tenaga kesehatan diajak merefleksikan pengalaman komunikasi yang dianggap berhasil maupun kurang berhasil dalam menyampaikan informed consent, kemudian mendiskusikannya secara kolektif. Pendekatan ini realistis karena memanfaatkan pengalaman lapangan sebagai sumber belajar utama, serta tidak memerlukan sumber daya tambahan yang besar. Refleksi semacam ini membantu tenaga kesehatan mengenali pola komunikasi yang efektif, termasuk dalam membaca karakter pasien dan menyesuaikan kedalaman komunikasi.

Pemanfaatan media bantu komunikasi standar, seperti lembar informasi singkat, infografik, atau video edukasi berdurasi pendek, juga dapat menjadi bagian

dari pelatihan komunikasi yang praktis. Pelatihan difokuskan pada cara menggunakan media tersebut secara strategis untuk mendukung komunikasi lisan, bukan menggantikannya. Dengan demikian, waktu tatap muka yang terbatas dapat digunakan secara lebih efektif untuk klarifikasi dan pengambilan keputusan, sementara informasi dasar telah disampaikan sebelumnya.

Contoh-contoh pelatihan ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi komunikasi tidak harus bersifat idealistik atau terpisah dari praktik pelayanan sehari-hari. Pelatihan komunikasi yang realistis justru menekankan keterampilan adaptif, efisiensi waktu, dan sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya pasien. Pendekatan ini relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, di mana kualitas komunikasi menjadi kunci untuk memastikan informed consent yang bermakna di tengah keterbatasan sumber daya.

Dalam pelaksanaan program kesehatan, informed consent harus diposisikan sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu layanan dan perlindungan hak pasien. Keterlibatan tenaga kesehatan non-dokter, seperti perawat, bidan, dan tenaga promosi kesehatan, juga perlu diperkuat agar proses pemberian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada momen tindakan medis semata.

#### **F. Komunikasi Tenaga Kesehatan – Pasien. Pendekatan Teoretis: Uncertainty Reduction Theory, Social Penetration Theory, dan Temperamen Pasien dalam Informed Consent**

---

Proses informed consent pada hakikatnya merupakan proses komunikasi interpersonal yang sarat dengan ketidakpastian. Pasien berada pada situasi di mana ia harus mengambil keputusan penting terkait tindakan medis, sering kali dalam kondisi emosional dan kognitif yang tidak stabil. Dalam konteks ini, Uncertainty Reduction Theory (URT) menjelaskan bahwa individu secara alamiah terdorong untuk mengurangi ketidakpastian melalui pencarian informasi, prediktabilitas perilaku, serta kejelasan makna dalam interaksi. Richard West dan Lynn H. Turner menegaskan bahwa komunikasi berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menurunkan ambiguitas dan meningkatkan rasa kontrol individu terhadap situasi yang dihadapi (West Richard & Turner Lynn H, 2008).

Sejalan dengan itu, Social Penetration Theory memandang komunikasi interpersonal sebagai proses bertahap yang bergerak dari lapisan permukaan menuju lapisan yang lebih dalam. Namun, dalam konteks medis, kedalaman komunikasi tidak selalu diarahkan pada penetrasi hingga inti kepribadian pasien, melainkan difokuskan pada lapisan pemahaman yang relevan dengan pengambilan keputusan medis. Proses komunikasi tenaga Kesehatan/dokter-pasien menuntut

pengelolaan kedalaman secara proporsional, yaitu mencapai tingkat pemahaman kognitif, kepercayaan, dan kesiapan pasien untuk menerima informasi risiko serta manfaat tindakan medis. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi dalam informed consent tidak diukur dari intensitas pengungkapan diri pasien, tetapi dari sejauh mana komunikasi mampu mendukung reduksi ketidakpastian dan pengambilan keputusan yang sadar, etis, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.”

Dalam kerangka tersebut, pengelolaan kedalaman komunikasi sebagaimana dijelaskan dalam Social Penetration Theory berfungsi sebagai mekanisme praktis untuk mencapai tujuan utama Uncertainty Reduction Theory, yakni menurunkan tingkat ketidakpastian pasien terhadap tindakan medis yang akan dijalani.

Dalam praktiknya, efektivitas pengelolaan kedalaman komunikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kesehatan mengenali karakter atau kecenderungan temperamen pasien, sehingga strategi komunikasi dapat disesuaikan secara adaptif tanpa melampaui batas profesional dan etika klinis. Selain itu pendekatan temperamen *sanguinis*, *koleris*, *melankolis*, dan *plegmatis* yang berasal dari tradisi kedokteran klasik juga digunakan dalam tulisan ini sebagai kerangka heuristik untuk memahami kecenderungan respons komunikasi pasien, bukan sebagai klasifikasi psikologis formal (Stelmack & Stalikas, 1991).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kemampuan dokter dalam mengenali karakter dan kecenderungan temperamen pasien berperan penting dalam keberhasilan proses komunikasi, khususnya pada tahap awal edukasi dan informed consent. Salah satu dokter bedah yang diwawancarai menyampaikan bahwa ketika ia dapat mengidentifikasi pasien dengan kecenderungan temperamen koleris, proses “masuk” atau membangun komunikasi menjadi lebih mudah karena pendekatan yang digunakan dapat langsung disesuaikan dengan cara berpikir pasien. Informan menekankan bahwa penggunaan bahasa awam yang mudah dipahami merupakan prinsip utama dalam menjelaskan tindakan medis, namun cara penyampaian tersebut sangat bergantung pada karakter, latar belakang budaya, serta respons komunikasi pasien yang beragam.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa perbedaan suku, budaya, dan karakter dasar pasien menuntut fleksibilitas komunikasi dari tenaga kesehatan. Pasien dengan kecenderungan sanguinis, melankolis, atau koleris memerlukan pendekatan yang berbeda sejak awal interaksi. Dalam konteks pasien koleris, misalnya, informan menyatakan bahwa pendekatan yang terlalu santai atau bercanda justru berpotensi menghambat komunikasi. Sebaliknya, pasien dengan karakter tersebut cenderung lebih menerima penjelasan yang disampaikan secara lugas, sistematis, dan berbasis rujukan ilmiah. Penyebutan sumber literatur atau

jurnal internasional dinilai mampu meningkatkan kepercayaan dan mempermudah penerimaan informasi medis.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa keterampilan membaca karakter pasien merupakan bagian penting dari kompetensi komunikasi tenaga kesehatan. Informan menegaskan bahwa kemampuan tersebut bersifat krusial, bahkan wajib dalam praktik klinis sehari-hari, mengingat tenaga kesehatan berhadapan langsung dengan manusia yang memiliki latar belakang dan karakteristik berbeda. Namun demikian, keterampilan komunikasi interpersonal semacam ini umumnya tidak diperoleh secara formal selama Pendidikan di bangku kuliah, melainkan berkembang melalui pengalaman praktik dan interaksi sosial. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki kesempatan atau kemauan untuk mengembangkan *soft skills* komunikasi, sehingga tingkat sensitivitas interpersonal dan kemampuan adaptasi komunikasi antar tenaga kesehatan menjadi beragam.

Dalam kerangka teori komunikasi, temuan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas informed consent tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan tenaga kesehatan menyesuaikan strategi komunikasi dengan karakter pasien. Pendekatan berbasis pengenalan temperamen berfungsi sebagai alat bantu praktis untuk mengelola kedalaman dan gaya komunikasi, sehingga proses reduksi ketidakpastian pasien dapat berlangsung secara lebih efektif dan etis.

Dalam perspektif Uncertainty Reduction Theory, kondisi pasien yang akan menjalani tindakan medis merupakan situasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, proses komunikasi dalam informed consent berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menurunkan ketidakpastian tersebut. Informan menjelaskan bahwa penyesuaian gaya komunikasi berdasarkan kecenderungan temperamen—seperti sanguinis, melankolis, plegmatis atau koleris—membantu dokter menentukan bentuk penyampaian informasi yang paling dapat diterima oleh pasien. Pada pasien dengan kecenderungan koleris, misalnya, pendekatan yang sistematis, lugas, dan berbasis rujukan ilmiah dinilai lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan mempercepat pemahaman, dibandingkan pendekatan yang bersifat santai atau emosional.

Temuan ini juga dapat dipahami melalui Social Penetration Theory, di mana komunikasi dokter-pasien berkembang secara bertahap dari lapisan informasi umum menuju lapisan pemahaman yang lebih relevan dengan pengambilan keputusan kesehatan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, penetrasi sosial tidak diarahkan pada pengungkapan diri yang mendalam, melainkan pada pencapaian tingkat pemahaman dan kepercayaan yang memadai agar pasien mampu mengambil keputusan secara sadar. Kemampuan tenaga kesehatan dalam

“membaca” karakter pasien berperan penting dalam menentukan sejauh mana kedalaman komunikasi perlu dicapai tanpa melampaui batas profesional dan etika pelayanan.

## **G. Simpulan**

---

Informed consent merupakan indikator penting dalam menilai kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan di era modern. Praktik informed consent yang berkualitas mencerminkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengintegrasikan kompetensi komunikasi, etika, dan hukum kesehatan dalam pelayanan. Refleksi dari praktik informed consent pada pelayanan klinis menunjukkan bahwa tantangan kompetensi masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, penguatan kompetensi tenaga kesehatan dalam praktik informed consent menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan program kesehatan berjalan secara efektif, etis, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien (World Health Organization, 2016; Elwyn et al., 2017). Upaya ini memerlukan dukungan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, serta integrasi pendekatan komunikasi kesehatan dalam setiap level pelayanan.

## **H. Referensi**

---

- Beauchamp, T. L. ., & Childress, J. F. . (2013). *Principles of biomedical ethics*. Oxford University Press.
- Elwyn, G., Barr, P. J., & Grande, S. W. (2017). Patients recording clinical encounters: A path to empowerment? *BMJ*, 358, j3791. <https://www.bmj.com/content/358/bmj.j3791>
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., Cording, E., Tomson, D., Dodd, C., Rollnick, S., Edwards, A., & Barry, M. (2012). Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice. *Journal of General Internal Medicine*, 27(10), 1361–1367. <https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6>
- Hall, D. E., Prochazka, A. V., & Fink, A. S. (2012). Informed consent for clinical treatment. *CMAJ*, 184(5), 533–540. <https://www.cmaj.ca/content/184/5/533>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/124820/permenkes-no-290-tahun-2008>

- Kunneman, M., Montori, V. M., Castaneda-Guarderas, A., & Hess, E. P. (2014). What is shared decision making? *BMJ*, 349, g7391. <https://www.bmj.com/content/349/bmj.g7391>
- Mulyana Deddy, & Rachmawati Devie. (2022). *Communication Technology and Society* (Aisha Sarah, Ed.; 1st ed.). Arti Bumi Intaran.
- Schenker, Y., Fernandez, A., Sudore, R., & Schillinger, D. (2011). Interventions to Improve Patient Comprehension in Informed Consent for Medical and Surgical Procedures. *Medical Decision Making*, 31(1), 151–173. <https://doi.org/10.1177/0272989X10364247>
- Stelmack, R. M., & Stalikas, A. (1991). Galen and the humour theory of temperament. *Personality and Individual Differences*, 12(3), 255–263. [https://doi.org/10.1016/0191-8869\(91\)90111-N](https://doi.org/10.1016/0191-8869(91)90111-N)
- Street, R. L., Makoul, G., Arora, N. K., & Epstein, R. M. (2009). How does communication heal? Pathways linking clinician–patient communication to health outcomes. *Patient Education and Counseling*, 74(3), 295–301. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2008.11.015>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/259365/uu-no-17-tahun-2023>
- West Richard, & Turner Lynn H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi* (3rd ed.). Salemba Humanika.
- Winarti Wiwin, Jamhur Budi Setiawan, Hakim Rendi Muhammad, & Maryani Dini. (2025). Kualitas Komunikasi Informed Consent Pra-Operasi di Edelweiss Hospital dan Implikasinya pada Pelayanan RS Tipe-C.
- World Health Organization. (2016). Framework on integrated, people-centred health services. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2016.8>
- World Health Organization. (2017). Communicating risk in public health emergencies. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-CPI-2017.7>

## **I. Glosarium**

---

Audiovisual edukasi: Media edukasi berupa video atau animasi untuk membantu pasien memahami diagnosis, prosedur, risiko, dan perawatan.

Bahasa awam: Bahasa sederhana yang mudah dipahami pasien, digunakan untuk menerjemahkan istilah medis agar tidak menimbulkan salah paham.

Citra profesionalisme: Gambaran kompetensi dan etika tenaga kesehatan yang terlihat dari kualitas komunikasi, keterbukaan informasi, dan pelaksanaan informed consent.

Dokter keluarga: Dokter yang memantau kesehatan keluarga dan dapat merujuk pasien ke fasilitas/layanan lebih lanjut sesuai kebutuhan medis.

Etika kedokteran/keperawatan: Standar perilaku profesi yang menekankan keselamatan pasien, kejujuran informasi, dan penghormatan terhadap hak pasien.

Formulir persetujuan: Dokumen tertulis persetujuan tindakan medis; bukan inti informed consent, melainkan bukti administratif dari proses komunikasi.

Hak pasien atas informasi: Hak pasien mengetahui diagnosis, prosedur, risiko, manfaat, prognosis, dan alternatif agar dapat memutuskan secara sadar.

Implied consent (persetujuan tersirat): Persetujuan yang dianggap ada melalui tindakan pasien dalam situasi rutin (misalnya pasien datang untuk pemeriksaan dan mengikuti prosedur standar).

Konsultasi terbatas: Kondisi konsultasi singkat karena antrean/beban kerja; sering menurunkan peluang klarifikasi dan tanya jawab.

Literasi kesehatan: Kemampuan seseorang memahami informasi kesehatan dan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan.





# CHAPTER 5

## PERAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN/ CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT(CPD)

Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep.

### A. Pendahuluan / Prolog

Pelayanan kesehatan di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi medis, perubahan pola penyakit, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap mutu layanan menuntut tenaga kesehatan untuk terus memperbarui kompetensi mereka. Pendidikan formal yang diperoleh di bangku kuliah tidak lagi cukup untuk menjawab dinamika praktik klinis yang terus berubah. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pembelajaran berkelanjutan yang mampu menjaga relevansi dan kualitas tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang optimal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Continuous Professional Development (CPD) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. CPD bukan sekadar pelatihan tambahan, melainkan suatu proses sistematis yang terintegrasi dalam perjalanan karier tenaga kesehatan. Melalui CPD, tenaga kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sehingga tetap kompeten dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (World Health Organization, 2025).

Urgensi CPD semakin jelas ketika dikaitkan dengan keselamatan pasien. Tenaga kesehatan yang tidak mengikuti perkembangan terbaru berisiko melakukan kesalahan klinis yang dapat berdampak pada mutu pelayanan. CPD memastikan bahwa tenaga kesehatan selalu mengacu pada praktik berbasis bukti (evidence-based practice), sehingga keputusan klinis yang diambil lebih akurat dan aman bagi pasien (World Health Organization, 2025).

Selain itu, CPD juga berfungsi sebagai sarana penguatan profesionalisme. Tenaga kesehatan yang aktif mengikuti CPD menunjukkan komitmen terhadap etika profesi, tanggung jawab sosial, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Profesionalisme yang terjaga melalui CPD tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memperkuat posisi tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan yang semakin kompetitif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Pentingnya CPD dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada sistem kesehatan secara keseluruhan. Tenaga kesehatan yang kompeten akan meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses pemulihan pasien, dan menurunkan angka kesalahan medis. Dengan demikian, CPD berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan kesehatan nasional maupun global (World Health Organization, 2025).

Secara global, CPD telah menjadi standar dalam pengembangan tenaga kesehatan. World Health Organization (WHO) menekankan bahwa CPD merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Data WHO tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 70% negara anggota telah mengintegrasikan CPD dalam kebijakan tenaga kesehatan (World Health Organization, 2025).

Fenomena CPD di tingkat global juga menunjukkan adanya tren digitalisasi. Platform daring dan e-learning menjadi sarana utama dalam penyelenggaraan CPD, terutama setelah pandemi COVID-19. Analisis Global Health Labor Market 2023 mencatat bahwa lebih dari 60% tenaga kesehatan di dunia mengikuti CPD berbasis digital sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan tatap muka (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Di Indonesia, CPD mulai diposisikan sebagai syarat penting dalam perpanjangan registrasi dan lisensi praktik tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan bersama organisasi profesi memperkuat tata kelola tenaga kesehatan melalui regulasi CPD. Langkah ini sejalan dengan pemantauan global terhadap cakupan kesehatan semesta dan target SDGs, khususnya tujuan ketiga tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan (World Health Organization, 2025).

Fenomena CPD di tingkat nasional juga terlihat dari berbagai inisiatif rumah sakit dan institusi pendidikan. Misalnya, program CPD berbasis patient-centered care yang dikembangkan sejak 2020 di beberapa rumah sakit rujukan telah meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan hingga 40% lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemic (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Program CPD di Indonesia tidak hanya berfokus pada dokter dan perawat, tetapi juga mencakup tenaga kesehatan lain seperti bidan, apoteker, dan tenaga rekam medis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat jumlah tenaga kesehatan di Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta orang, dengan distribusi terbesar pada perawat dan bidan. Hal ini menunjukkan bahwa CPD bersifat inklusif dan lintas profesi (Badan Pusat Statistik, 2024).

Namun, implementasi CPD di Indonesia masih menghadapi tantangan. Keterbatasan akses, biaya, serta kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan utama. Meski demikian, perkembangan teknologi digital

membuka peluang besar untuk mengatasi hambatan tersebut melalui platform daring dan e-learning, yang memungkinkan tenaga kesehatan di daerah terpencil tetap dapat mengikuti CPD (Badan Pusat Statistik, 2024).

Dengan adanya CPD, tenaga kesehatan diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan paradigma pelayanan, seperti digitalisasi rekam medis, telemedicine, dan penggunaan artificial intelligence dalam diagnosis. Kompetensi baru ini hanya dapat dicapai melalui pembelajaran berkelanjutan yang terstruktur dan terarah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

Berdasarkan fenomena global dan nasional, CPD terbukti menjadi kebutuhan mendesak bagi tenaga kesehatan. CPD bukan hanya instrumen peningkatan kompetensi, tetapi juga strategi untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan menguraikan urgensi CPD, konsep dasar, manfaat, serta implementasi di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran CPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

## **B. Konsep dasar CPD dan pentingnya**

---

Continuous Professional Development (CPD) merupakan suatu pendekatan pendidikan berkelanjutan yang dirancang untuk memastikan tenaga kesehatan tetap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai tuntutan perkembangan zaman. CPD tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan tambahan, tetapi menjadi bagian integral dari perjalanan karier tenaga kesehatan agar tetap relevan dan kompeten dalam memberikan pelayanan.

CPD terdiri dari berbagai bentuk kegiatan pendidikan yang fleksibel dan adaptif. Bentuk kegiatan tersebut meliputi konferensi, seminar, lokakarya, pelatihan klinis, serta program daring (online learning) yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Metode ini penting karena memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk membahas praktik terbaru, memperbarui pengetahuan berbasis bukti, serta berbagi pengalaman dengan rekan seprofesi (Nilasari et al., 2021).

Selain aspek teknis, CPD yang efektif juga berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal. Keterampilan komunikasi, empati, dan kolaborasi antarprofesi menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan modern. Studi terbaru menunjukkan bahwa CPD yang mengintegrasikan keterampilan komunikasi membantu tenaga kesehatan lebih memahami kebutuhan pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam konteks kesehatan mental (Patandean, 2024). Pentingnya CPD dapat dijelaskan dalam beberapa tingkatan:

1. Individu: CPD meningkatkan kompetensi klinis, keterampilan interpersonal, dan profesionalisme tenaga kesehatan.

2. Organisasi: CPD memperkuat budaya pembelajaran di rumah sakit atau institusi kesehatan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta menurunkan angka kesalahan medis.
3. Sistem kesehatan: CPD berkontribusi pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ketiga tentang kesehatan yang baik dan kesejahteraan (Putri & Rohana, 2020).

Fenomena global menunjukkan bahwa CPD telah menjadi standar dalam pengembangan tenaga kesehatan. WHO menegaskan bahwa lebih dari 70% negara anggota telah mengintegrasikan CPD dalam kebijakan tenaga kesehatan sejak 2020, dengan tren digitalisasi yang semakin kuat pasca pandemi COVID-19. Platform daring terbukti meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan kesempatan belajar bagi tenaga kesehatan di berbagai wilayah.

Di tingkat nasional, Indonesia mulai memperkuat regulasi CPD sebagai syarat perpanjangan registrasi tenaga kesehatan. Survei pelaksanaan CPD pada perawat di Makassar tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 65% tenaga kesehatan aktif mengikuti CPD, meski masih terdapat kendala akses di daerah terpencil (Patandean, 2024). Program CPD berbasis patient-centered care yang dikembangkan RS Mata "Dr. Yap" sejak 2020 juga berhasil meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dan memperkuat sistem rujukan (Putri & Rohana, 2020).

Lebih lanjut, pengalaman negara berkembang seperti Ghana menunjukkan bahwa CPD yang terstruktur mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di komunitas lokal. Hal ini menegaskan bahwa investasi dalam CPD tidak hanya berdampak pada tenaga kesehatan secara individu, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat (Nilasari et al., 2021).

Dengan demikian, CPD memiliki peran strategis dalam memastikan tenaga kesehatan tetap kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perubahan. Konsep dasar CPD yang menekankan pembelajaran berkelanjutan, serta pentingnya CPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menjadikannya sebagai pilar utama dalam pembangunan sistem kesehatan modern.

### **C. Peran pelatihan dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan**

---

Pelatihan merupakan salah satu strategi utama dalam Continuous Professional Development (CPD) yang bertujuan untuk menjaga relevansi dan kompetensi tenaga kesehatan. Di era modern, pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pengembangan keterampilan praktis dan sikap profesional yang sesuai dengan tuntutan pelayanan kesehatan.

Pelatihan yang dirancang dengan baik dapat membantu tenaga kesehatan memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka secara kontinu. Hal ini penting

karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan berlangsung sangat cepat, sehingga tenaga kesehatan harus selalu siap beradaptasi.

Metodologi pembelajaran aktif menjadi salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam pelatihan tenaga kesehatan. Diskusi kelompok, simulasi, dan praktik langsung memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dibandingkan metode ceramah tradisional. Studi terbaru menunjukkan bahwa metode aktif meningkatkan motivasi, keterlibatan, serta komitmen tenaga kesehatan terhadap CPD (Farid et al., 2025).

Simulasi klinis, misalnya, telah digunakan secara luas dalam pendidikan kedokteran dan keperawatan. Dengan simulasi, tenaga kesehatan dapat berlatih menghadapi situasi kritis tanpa membahayakan pasien. Penelitian oleh Farid et al. (2025) menegaskan bahwa simulasi meningkatkan keterampilan klinis sekaligus kepercayaan diri tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan.

Selain simulasi, praktik langsung di lapangan juga menjadi bagian penting dari pelatihan. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam praktik klinis terstruktur dapat mengintegrasikan teori dengan pengalaman nyata, sehingga kompetensi mereka lebih komprehensif.

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi merupakan elemen penting dalam program pelatihan. Kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik tenaga kesehatan dan mencerminkan perkembangan di bidang medis. Misalnya, pelatihan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, seperti rekam medis elektronik, sangat relevan di era digital (Seelam, 2025). Kurikulum berbasis kompetensi juga memastikan bahwa pelatihan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada keterampilan praktis dan sikap profesional. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat lebih siap menghadapi tantangan di lapangan.

Salah satu pendekatan yang efektif dalam pelatihan berkelanjutan adalah *problem-based learning* (PBL). Melalui PBL, tenaga kesehatan diajak untuk menyelesaikan kasus nyata yang mungkin mereka hadapi dalam praktik. Pendekatan ini meningkatkan keterampilan analitis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan (Saini & Ruhela, 2025).

Model PBL telah diadopsi di berbagai institusi pendidikan medis dan terbukti menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi dunia kerja. Penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang dilatih dengan PBL memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional.

Selain metode pembelajaran, evaluasi pelatihan juga menjadi aspek penting. Pelatihan harus selalu diperbarui berdasarkan umpan balik dari peserta. Evaluasi ini memastikan bahwa materi pelatihan tetap relevan dengan kebutuhan praktis tenaga

kesehatan(Farid et al., 2025). Keterlibatan peserta dalam proses penyusunan kurikulum dan evaluasi program CPD merupakan langkah penting untuk menciptakan pelatihan yang sesuai dengan harapan mereka. Dengan melibatkan peserta, pelatihan menjadi lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Pelatihan juga berperan dalam meningkatkan keterampilan interpersonal tenaga kesehatan. Komunikasi efektif, empati, dan kolaborasi antarprofesi menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan modern. CPD yang mengintegrasikan keterampilan ini terbukti meningkatkan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien(Saini & Ruhela, 2025).

Dalam konteks global, pelatihan berbasis CPD telah terbukti meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Laporan iCPD (2025) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mendorong transformasi besar dalam CPD, dengan adopsi luas pembelajaran daring dan kredensial digital(Seelam, 2025).

Di Indonesia, pelatihan CPD mulai difokuskan pada pemanfaatan teknologi digital. Platform e-learning memungkinkan tenaga kesehatan di daerah terpencil untuk tetap mengikuti pelatihan tanpa harus berpindah lokasi. Hal ini membantu pemerataan kompetensi tenaga kesehatan di seluruh wilayah. Pelatihan berbasis teknologi juga mencakup penggunaan telemedicine dan artificial intelligence dalam diagnosis. Kompetensi baru ini hanya dapat dicapai melalui pelatihan berkelanjutan yang terstruktur.

Selain aspek teknis, pelatihan juga berfungsi sebagai sarana penguatan profesionalisme. Tenaga kesehatan yang aktif mengikuti pelatihan menunjukkan komitmen terhadap etika profesi dan tanggung jawab sosial. Pelatihan yang berkelanjutan juga berdampak pada sistem kesehatan secara keseluruhan. Tenaga kesehatan yang kompeten meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat pemulihan pasien, dan menurunkan angka kesalahan medis(Saini & Ruhela, 2025).

Dengan demikian, pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Pelatihan yang dirancang dengan baik, berbasis kompetensi, menggunakan metode aktif, serta dievaluasi secara berkelanjutan akan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan modern.

#### **D. Pengembangan Berkelanjutan: Kunci untuk Profesionalisme**

---

Di tengah arus perubahan yang cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, profesionalisme tenaga kesehatan tidak lagi cukup dijaga hanya melalui pendidikan formal. Dunia praktik klinis menuntut pembaruan kompetensi secara terus-menerus agar tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan yang aman,



efektif, dan berbasis bukti. Dalam konteks ini, Continuous Professional Development (CPD) menjadi kunci utama pengembangan berkelanjutan yang menopang profesionalisme.

CPD bukan sekadar pelatihan tambahan, melainkan proses sistematis yang memungkinkan tenaga kesehatan mengevaluasi dan memperbarui keterampilan mereka secara berkala. Melalui CPD, tenaga kesehatan dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam praktik klinis, teknologi medis, dan kebijakan pelayanan, sehingga mereka tetap relevan dan kompeten dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Salah satu aspek penting dari CPD adalah kemampuannya untuk menjembatani antara teori dan praktik. Pelatihan berkelanjutan memungkinkan tenaga kesehatan menerjemahkan pengetahuan baru menjadi tindakan klinis yang efektif. Misalnya, dalam bidang kedokteran, penerapan evidence-based medicine (EBM) menuntut tenaga kesehatan untuk selalu mengakses dan memahami hasil penelitian terkini serta panduan klinis terbaru.

Penelitian oleh Nash et al., (2017) dan Salmi (2021) menunjukkan bahwa CPD yang terintegrasi dengan pengajaran EBM secara signifikan meningkatkan keterampilan klinis dan pengambilan keputusan tenaga kesehatan. Hal ini memperkuat argumen bahwa pengembangan berkelanjutan bukan hanya kebutuhan, tetapi juga strategi untuk menjaga kualitas layanan kesehatan.

Selain peningkatan kompetensi teknis, CPD juga berperan dalam membangun profesionalisme melalui penguatan nilai-nilai etika, komunikasi, dan kolaborasi. Tenaga kesehatan yang aktif dalam CPD cenderung memiliki sikap profesional yang lebih kuat, seperti tanggung jawab terhadap pasien, keterbukaan terhadap pembaruan, dan komitmen terhadap standar mutu.

CPD juga menciptakan ruang bagi tenaga kesehatan untuk membangun jaringan profesional yang kuat. Platform CPD yang memungkinkan pertukaran informasi dan pengalaman antarprofesi terbukti meningkatkan integrasi tim medis. Pelatihan antarprofesi yang melibatkan dokter, perawat, dan apoteker, seperti yang diteliti oleh Phillips et al. (2019) menunjukkan peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan pasien kompleks.

Jaringan profesional yang terbentuk melalui CPD tidak hanya mendukung karier individu, tetapi juga memperkuat sistem pelayanan secara keseluruhan. Kolaborasi yang efektif antarprofesi menghasilkan keputusan klinis yang lebih komprehensif dan pelayanan yang lebih terintegrasi.

Dari perspektif organisasi, CPD memberikan dampak positif terhadap produktivitas, retensi tenaga kerja, dan kepuasan pasien. Organisasi yang mendukung CPD menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pembelajaran,



inovasi, dan peningkatan mutu. Studi oleh Hammoud et al. (2024) di sektor kesehatan Eropa menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas tenaga kesehatan melalui CPD berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Di Indonesia, CPD telah mulai diintegrasikan dalam sistem registrasi tenaga kesehatan melalui mekanisme Satuan Kredit Profesi (SKP). Petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) menegaskan bahwa pelatihan terakreditasi yang bernilai SKP menjadi syarat perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR), yang menandakan pengakuan formal terhadap pentingnya pengembangan berkelanjutan.

Pedoman dari IAKMI (2018) juga menekankan bahwa tenaga kesehatan masyarakat wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran berkelanjutan.

CPD yang efektif harus dirancang secara kontekstual, sesuai dengan kebutuhan lokal dan spesifikasi profesi. Misalnya, pelatihan tentang rekam medis elektronik, telemedicine, dan manajemen penyakit kronis menjadi sangat relevan di era digital dan pandemi. Program CPD yang responsif terhadap kebutuhan ini akan lebih berdampak dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.

Evaluasi berkala terhadap program CPD juga menjadi bagian penting dari pengembangan berkelanjutan. Umpan balik dari peserta, analisis dampak pelatihan terhadap praktik klinis, dan penyesuaian kurikulum berdasarkan tren terbaru adalah langkah-langkah yang memastikan CPD tetap relevan dan efektif.

Dengan demikian, pengembangan berkelanjutan melalui CPD bukan hanya alat peningkatan kompetensi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk membangun profesionalisme tenaga kesehatan. CPD yang terstruktur, adaptif, dan kolaboratif akan menghasilkan tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga tangguh secara etika dan sosial dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan modern.

## **E. Tantangan era modern terhadap pelatihan sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan**

---

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern membawa implikasi besar terhadap dunia kesehatan. Tenaga kesehatan dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan berkelanjutan yang terintegrasi dalam Continuous Professional Development (CPD). Namun, pelaksanaan pelatihan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang

kompleks. Tantangan ini mencakup aspek teknologi, aksesibilitas, beban kerja, kebijakan, hingga keterbatasan sumber daya, yang semuanya memengaruhi efektivitas CPD dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.

Salah satu tantangan utama adalah kecepatan perkembangan teknologi kesehatan. Digitalisasi pelayanan, seperti rekam medis elektronik, telemedicine, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam diagnosis, menuntut tenaga kesehatan untuk segera beradaptasi. Namun, tidak semua institusi memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung pelatihan berbasis teknologi. World Health Organization (2022) menekankan bahwa transformasi digital dalam pelayanan kesehatan hanya dapat berjalan efektif jika tenaga kesehatan dibekali dengan pelatihan yang sesuai, sehingga mereka mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik klinis.

Selain itu, kesenjangan akses terhadap pelatihan CPD masih menjadi masalah serius, terutama di negara berkembang. Tenaga kesehatan di daerah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan jaringan internet, minimnya fasilitator, dan kurangnya dukungan institusional. Studi World Health Organization Indonesia, (2025) menunjukkan bahwa hanya 48% tenaga kesehatan di wilayah non-perkotaan memiliki akses rutin terhadap pelatihan CPD berbasis daring. Hal ini menimbulkan ketimpangan kompetensi antara tenaga kesehatan di perkotaan dan pedesaan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.

Beban kerja yang tinggi juga menjadi penghalang partisipasi aktif dalam pelatihan. Tenaga kesehatan di fasilitas dengan rasio pasien tinggi sering kali tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti pelatihan, meskipun mereka sangat membutuhkannya. Menurut Hammoud et al. (2024), tekanan kerja yang berlebihan dapat menurunkan motivasi tenaga kesehatan untuk terlibat dalam CPD, sehingga pelatihan harus dirancang fleksibel dan adaptif terhadap jadwal kerja mereka.

Tantangan lain adalah kurangnya integrasi antara pelatihan dan kebutuhan praktik klinis. Banyak program CPD masih bersifat generik dan tidak kontekstual, sehingga kurang relevan dengan tantangan nyata di lapangan. Salmi (2021) menegaskan bahwa CPD yang tidak berbasis kebutuhan lokal cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi klinis. Oleh karena itu, pelatihan harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan tenaga kesehatan di masing-masing wilayah.

Dari sisi kebijakan, regulasi CPD di Indonesia masih menghadapi kendala konsistensi. Meskipun CPD telah menjadi syarat perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR), belum semua organisasi profesi memiliki sistem akreditasi pelatihan yang terstandarisasi. Hal ini menyebabkan variasi kualitas pelatihan dan

kebingungan di kalangan tenaga kesehatan mengenai program yang diakui secara resmi (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Keterbatasan dana juga menjadi hambatan serius. Banyak institusi kesehatan, terutama di sektor publik, tidak memiliki anggaran khusus untuk pelatihan berkelanjutan. Akibatnya, pelatihan CPD sering kali bergantung pada inisiatif pribadi tenaga kesehatan atau dukungan dari pihak ketiga, seperti LSM atau donor internasional. Phillips et al. (2019) menekankan bahwa investasi dalam CPD harus dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan sekadar biaya tambahan.

Selain hambatan, era modern juga membuka peluang baru melalui teknologi digital. Platform Learning Management System (LMS), webinar interaktif, dan modul e-learning memungkinkan pelatihan dilakukan secara fleksibel dan hemat biaya. Namun, pemanfaatan teknologi ini memerlukan literasi digital yang memadai. Tenaga kesehatan yang tidak terbiasa dengan teknologi digital berisiko tertinggal dalam mengikuti CPD berbasis daring (Saini & Ruhela, 2023).

Perbedaan generasi tenaga kesehatan juga memengaruhi dinamika pelatihan. Generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi cenderung lebih terbuka terhadap metode pembelajaran daring, sementara generasi senior mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan konvensional. Oleh karena itu, desain pelatihan harus mempertimbangkan keberagaman demografis peserta agar efektif bagi semua kelompok usia.

Resistensi terhadap perubahan menjadi tantangan lain yang cukup signifikan. Sebagian tenaga kesehatan masih memandang CPD sebagai beban administratif, bukan sebagai kebutuhan profesional. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih persuasif dan berbasis nilai untuk membangun kesadaran akan pentingnya CPD (Farid et al., 2025).

Krisis kesehatan global seperti pandemi COVID-19 juga memperlihatkan betapa pentingnya pelatihan yang responsif dan cepat. Namun, banyak negara mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan pelatihan darurat yang terstandarisasi. Laporan iCPD (2025) menegaskan bahwa pandemi mendorong transformasi besar dalam CPD, dengan adopsi luas pembelajaran daring dan kredensial digital sebagai solusi adaptif.

Tantangan era modern juga mencakup aspek etika dan keamanan data. Pelatihan yang melibatkan teknologi digital harus memperhatikan perlindungan data pasien dan privasi informasi. Oleh karena itu, CPD harus mencakup literasi digital dan etika penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan (WHO, 2022).

Dalam konteks interprofesional, koordinasi antarprofesi juga menjadi tantangan. Pelatihan CPD yang melibatkan berbagai profesi kesehatan sering kali

menghadapi kendala dalam menyatukan kurikulum, jadwal, dan pendekatan pembelajaran. Padahal, pelatihan lintas profesi sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan pasien kompleks (Phillips et al., 2019).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan sistemik yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat ekosistem CPD yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan juga menjadi kunci. Program CPD harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, seperti peningkatan kompetensi, perubahan perilaku klinis, dan dampak terhadap kualitas pelayanan. Tanpa evaluasi, pelatihan berisiko menjadi kegiatan rutin tanpa hasil nyata (Ramani et al., 2019). Dengan memahami tantangan era modern, pelatihan CPD dapat dirancang lebih strategis dan berdampak. Pelatihan yang kontekstual, berbasis teknologi, dan didukung oleh kebijakan yang kuat akan menjadi fondasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di masa depan.

## **F. Simpulan**

---

Bab ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di era modern tidak dapat dilepaskan dari strategi pengembangan berkelanjutan melalui pelatihan dan program Continuous Professional Development (CPD). Perubahan cepat dalam ilmu pengetahuan, teknologi medis, dan tuntutan pelayanan menuntut tenaga kesehatan untuk terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka. Dalam konteks ini, CPD bukan hanya menjadi pelengkap pendidikan formal, tetapi telah bertransformasi menjadi fondasi profesionalisme dan kualitas layanan kesehatan.

Konsep dasar CPD mencakup berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, mulai dari seminar, lokakarya, praktik klinis, hingga pelatihan berbasis teknologi digital. CPD yang efektif tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pada penguatan keterampilan interpersonal, seperti komunikasi, empati, dan kolaborasi antarprofesi. Dengan pendekatan ini, CPD mampu menjawab tantangan multidimensi dalam pelayanan kesehatan modern.

Pelatihan sebagai bagian dari CPD memiliki peran strategis dalam membentuk tenaga kesehatan yang profesional dan siap menghadapi kompleksitas praktik klinis. Metode pembelajaran aktif seperti simulasi, diskusi kelompok, dan problem-based learning terbukti meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kemampuan analitis tenaga kesehatan. Kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang sesuai kebutuhan lokal menjadi kunci agar pelatihan berdampak nyata terhadap praktik pelayanan.

Pengembangan berkelanjutan melalui CPD juga berkontribusi terhadap pembentukan jaringan profesional yang kuat. Platform CPD yang mendorong pertukaran informasi dan pengalaman antarprofesi memperkuat integrasi tim medis dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pasien. Selain itu, organisasi yang mendukung CPD cenderung memiliki tingkat retensi tenaga kerja yang lebih tinggi dan kepuasan pasien yang lebih baik, sebagaimana ditunjukkan oleh studi Hammoud et al. (2024).

Namun, pelaksanaan CPD di era modern tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kesenjangan akses, keterbatasan dana, beban kerja tinggi, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan yang harus diatasi secara sistemik. Tantangan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan transformasi digital, yang menuntut literasi teknologi dan etika penggunaan data dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, CPD harus dirancang secara kontekstual, inklusif, dan berbasis evaluasi berkelanjutan.

Model integratif CPD yang mencakup input, proses, output, dan dampak menjadi kerangka penting dalam merancang pelatihan yang efektif. Input berupa kebutuhan kompetensi dan dukungan kebijakan harus diolah melalui proses pelatihan yang fleksibel dan kolaboratif, menghasilkan output berupa peningkatan keterampilan dan profesionalisme, serta berdampak pada kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan kesehatan nasional dan global.

Dalam konteks Indonesia, penguatan regulasi CPD melalui mekanisme SKP dan pelatihan terakreditasi menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang berdaya saing. Namun, upaya ini harus didukung oleh inovasi pelatihan, kemitraan lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi agar CPD dapat menjangkau seluruh tenaga kesehatan secara merata dan berkelanjutan.

Sebagai simpulan, CPD merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia kesehatan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada mutu. Pelatihan yang dirancang secara sistematis, berbasis kebutuhan, dan didukung oleh kebijakan yang kuat akan menjadi fondasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di era modern. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, CPD dapat menjadi motor penggerak transformasi pelayanan kesehatan menuju sistem yang lebih inklusif, efisien, dan berkeadilan.

## G. Referensi

- Farid, D., Lumibao, J., Safar, F., Kassem, L., Gul, Z., Hams, S. Al, & Abiad, M. Al. (2025). BMC Medical Education Article in Press Evaluating the effectiveness of continuing professional development training program : a retrospective cohort study IN IN. *BMC Medical Education*, 0–42. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-08415-w>
- Hammoud, M. M., Schoppen, Z., Berkowitz, L. R., & Marzano, D. (2024). Redesigning Continuous Professional Development: Aligning Learning Needs With Clinical Practice. *Clinical Obstetrics & Gynecology*, 67(3), 474–482. <https://doi.org/10.1097/grf.0000000000000878>
- IAKMI. (2018). *Pedoman program pengembangan keprofesian berkelanjutan* (pp. 0–11).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan terakreditasi bernilai satuan kredit profesi skp*.
- Nash, R., Thompson, W., Stupans, I., Lau, E., Santos, J. M. S., Brown, N., Nissen, L., & Chalmers, L. (2017). CPD Aligned to Competency Standards to Support Quality Practice. *Pharmacy*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.3390/pharmacy5010012>
- Nilasari, P., Saraswasta, I. W. G., Agustina, F. U., & Ayu, V. (2021). Upaya Pengembangan Sumber Daya Keperawatan melalui CPD ( Continuing Professional Development ). *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, 4(1). <https://doi.org/10.32584/jkkm.v4i1.936>
- Patandean, D. (2024). *Survei pelaksanaan continuing professional development (pengembangan profesionalitas berkelanjutan) pada perawat di kota Makassar* (pp. 1–34). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/38801/1/R012211028>
- Phillips, J., Heneka, N., Bhattarai, P., Fraser, C., & Shaw, T. (2019). Effectiveness of the Spaced Education Pedagogy for Clinicians' Continuing Professional Development: A Systematic Review. *Medical Education*, 53(9), 886–902. <https://doi.org/10.1111/medu.13895>
- Putri, Y., & Rohana, D. (2020). *Penguatan kolaborasi jejaring RS Mata "Dr.YAP" melalui program continuing professional development tenaga kesehatan* (pp. 1–11). <https://www.persi.or.id/wp-content/uploads/2023/11/9.K9>
- Ramani, S., McMahon, G. T., Armstrong, E. G., Ramani, S., McMahon, G. T., & Armstrong, E. G. (2019). Continuing professional development to foster behaviour change : From principles to practice in health professions education Continuing professional development to foster behaviour change: From principles to practice in health professions education. *Medical Teacher*, 41(0), 1–8. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2019.1615608>
- Saini, S., & Ruhela, S. (2025). Impact of Continuous Professional Development ( CPD

) on Healthcare Outcomes. *Jagannath University Journal of Research and Review (JUJRR)*, 01(02), 153–158.

Salmi, I. A. (2021). The Lived Experience of Nurses Working in Cardiology Services With Online Continuing Professional Programs in Advancing Their Specialized Clinical Practice: Phenomenology Study Methodology. *Clinical Cardiology and Cardiovascular Interventions*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.31579/2641-0419/102>

Seelam, N. (2025). *Five Years Since The COVID-19 Pandemic: A Statistical Analysis Of The Transformation In CPD*. CPD Institute.

World Health Organization. (2022). *Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030: Reporting at Seventy-fifth World Health Assembly* (pp. 19–20). WHO.

World Health Organization. (2025). *From data to delivery: Indonesia strengthens health workforce governance , global UHC and SDG monitoring* (Issue December 2024, pp. 2024–2026). WHO Indonesia.

## H. Glosarium

---

Continuous Professional Development (CPD): Pengembangan profesional berkelanjutan; proses sistematis pembelajaran sepanjang hayat bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi.

Kompetensi: Kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas profesional secara efektif dan sesuai standar.

Profesionalisme: Sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap etika profesi, tanggung jawab sosial, dan mutu pelayanan dalam praktik kesehatan.

Pelatihan Berkelanjutan: Kegiatan pendidikan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur untuk memperbarui dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan.

Kurikulum Berbasis Kompetensi: Desain pembelajaran yang berfokus pada pencapaian kompetensi tertentu, disesuaikan dengan kebutuhan praktik dan perkembangan ilmu kesehatan.

Simulasi Klinis: Metode pelatihan yang menggunakan skenario atau alat bantu untuk meniru situasi klinis nyata, memungkinkan peserta berlatih tanpa risiko terhadap pasien.

Problem-Based Learning (PBL): Metode pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah nyata, mendorong peserta untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan kasus klinis.

Evidence-Based Medicine (EBM): Praktik medis yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini, dikombinasikan dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien.

Interprofessional Collaboration: Kolaborasi antara berbagai profesi kesehatan (misalnya dokter, perawat, apoteker) dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi dan holistik.

Learning Management System (LMS): Platform digital yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, dan mengevaluasi pelatihan daring secara sistematis.

Satuan Kredit Profesi (SKP): Sistem penilaian kuantitatif terhadap kegiatan CPD yang diakui oleh organisasi profesi dan digunakan sebagai syarat perpanjangan registrasi tenaga kesehatan.

Universal Health Coverage (UHC): Cakupan kesehatan semesta; kondisi di mana semua orang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa kesulitan finansial.

Sustainable Development Goals (SDGs): Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB, termasuk target kesehatan yang menekankan akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan kesehatan.

Literasi Digital: Kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi teknologi digital secara efektif dan etis dalam konteks pelayanan kesehatan.

Evaluasi Pelatihan: Proses penilaian terhadap efektivitas pelatihan CPD, mencakup umpan balik peserta, dampak terhadap praktik klinis, dan relevansi materi.







# CHAPTER 6

## TANTANGAN DAN STRATEGI MENINGKATKAN PROFESIONALISME TENAGA KESEHATAN



Intan Rina Susilawati, S.ST., Bdn., M.Keb.

### A. Pendahuluan / Prolog

---

Profesionalisme tenaga kesehatan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Di era modern, tenaga kesehatan dihadapkan pada dinamika perubahan yang sangat cepat, baik dari aspek perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan regulasi, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan. Kondisi ini menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang memadai, tetapi juga kemampuan adaptasi, integritas moral, serta komitmen terhadap nilai-nilai etika profesi.

Transformasi sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks turut memengaruhi peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Digitalisasi layanan, penerapan praktik berbasis bukti, serta pendekatan pelayanan yang berpusat pada pasien menuntut profesionalisme yang lebih komprehensif. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya, tingginya beban kerja, serta tekanan psikososial menjadi tantangan nyata yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan kinerja profesional tenaga kesehatan.

Bab ini membahas secara sistematis tantangan utama dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan di era modern serta menguraikan strategi berbasis kebijakan, praktik, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang dapat diterapkan untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan secara berkelanjutan. Pembahasan disusun secara analitis dengan mengintegrasikan perspektif global dan kebijakan kesehatan nasional sehingga relevan dengan konteks pelayanan kesehatan di Indonesia.

### B. Konsep Profesionalisme Tenaga Kesehatan

---

Profesionalisme tenaga kesehatan dapat dimaknai sebagai integrasi antara pengetahuan ilmiah, keterampilan klinis, sikap etis, serta perilaku profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Profesionalisme tidak hanya tercermin dari kemampuan teknis dalam praktik klinik, tetapi juga dari komitmen terhadap standar

pelayanan, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap hak dan martabat pasien.

Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, profesionalisme mencakup kemampuan komunikasi efektif, kerja sama interprofesional, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta kesiapan untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Oleh karena itu, profesionalisme bersifat dinamis dan harus terus dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

### **1. Dimensi Profesionalisme Dalam Pelayanan Kesehatan**

Profesionalisme tenaga kesehatan memiliki beberapa dimensi utama yang saling berkaitan, meliputi dimensi kompetensi, etika, tanggung jawab sosial, dan akuntabilitas. Dimensi kompetensi menuntut tenaga kesehatan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terus diperbarui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan klinis, tetapi juga pemahaman terhadap sistem pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

Dimensi etika berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap kode etik profesi, penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, serta perlindungan hak pasien. Tenaga kesehatan dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice dalam setiap tindakan profesional. Sementara itu, dimensi tanggung jawab sosial menempatkan tenaga kesehatan sebagai agen perubahan dalam masyarakat, khususnya dalam upaya promotif dan preventif kesehatan.

Dimensi akuntabilitas menuntut tenaga kesehatan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan profesional secara ilmiah, hukum, dan moral. Keempat dimensi tersebut membentuk landasan profesionalisme yang utuh dan menjadi prasyarat utama dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

## **C. Tantangan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Di Era Modern**

---

Pembahasan tantangan profesionalisme tenaga kesehatan di era modern tidak dapat dilepaskan dari konteks transformasi sistem kesehatan global dan nasional. Perubahan demografi, epidemiologi penyakit, kemajuan teknologi, serta reformasi kebijakan kesehatan menuntut tenaga kesehatan untuk beradaptasi secara cepat dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensi dan saling terkait, sehingga memerlukan pemahaman yang komprehensif agar strategi penguatan profesionalisme dapat dirancang secara tepat.

### **1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi**

Kemajuan teknologi kesehatan, termasuk sistem informasi kesehatan dan telemedicine, menuntut tenaga kesehatan untuk terus memperbarui kompetensi. Ketidaksiapan dalam mengadopsi teknologi baru dapat menurunkan efektivitas pelayanan dan berpotensi menghambat profesionalisme.

### **2. Beban Kerja Dan Keterbatasan Sumber Daya**

Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, tingginya beban kerja, serta keterbatasan fasilitas pendukung sering kali berdampak pada kelelahan kerja dan menurunnya kualitas pelayanan. Kondisi ini dapat memengaruhi kepatuhan terhadap standar profesional dan keselamatan pasien.

### **3. Tantangan Etika Dan Aspek Hukum**

Tenaga kesehatan semakin sering dihadapkan pada dilema etika dan risiko hukum, seperti perlindungan data pasien, informed consent, dan pengambilan keputusan klinis yang kompleks. Kurangnya pemahaman terhadap aspek etikolegal dapat berdampak pada citra profesional dan kepercayaan masyarakat.

### **4. Ekspektasi Masyarakat Yang Semakin Tinggi**

Masyarakat modern memiliki tingkat literasi kesehatan yang lebih baik dan menuntut pelayanan yang transparan, aman, dan manusiawi. Hal ini menuntut tenaga kesehatan untuk memiliki kemampuan komunikasi empatik dan profesional dalam setiap interaksi pelayanan.

### **5. Kesejahteraan Dan Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan**

Stres kerja, kelelahan emosional, dan risiko burnout merupakan tantangan serius yang dapat menurunkan kinerja dan profesionalisme tenaga kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik.

## **D. Strategi Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Di Indonesia**

---

### **1. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan**

Penguatan profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia perlu diarahkan pada sistem pengembangan profesional berkelanjutan yang terstruktur dan terstandar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Arah kebijakan tersebut selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2025–2029 yang menempatkan penguatan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan nasional. Renstra Kemenkes 2025–2029 menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, pemerataan tenaga kesehatan, serta pengembangan kapasitas berkelanjutan

untuk menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tidak hanya berfungsi untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga sebagai sarana adaptasi terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Penguatan profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia perlu diarahkan pada sistem pengembangan profesional berkelanjutan yang terstruktur dan terstandar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan penguatan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, beretika, dan berdaya saing. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tidak hanya berfungsi untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga sebagai sarana adaptasi terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, pendidikan berkelanjutan harus dirancang berbasis kebutuhan (*needs-based learning*), memperhatikan kesenjangan kompetensi yang ada di lapangan. Program pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan praktik berpotensi menjadi tidak efektif dan hanya bersifat administratif. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan kompetensi tenaga kesehatan secara berkala sebagai dasar perencanaan pelatihan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi pembelajaran digital seperti *e-learning*, *blended learning*, dan simulasi berbasis teknologi menjadi alternatif strategis untuk menjangkau tenaga kesehatan di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil. Pendekatan ini juga mendukung prinsip pembelajaran sepanjang hayat yang menjadi karakter utama profesionalisme tenaga kesehatan.

Penguatan profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia perlu diarahkan pada sistem pengembangan profesional berkelanjutan yang terstruktur dan terstandar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan penguatan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, beretika, dan berdaya saing. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tidak hanya berfungsi untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga sebagai sarana adaptasi terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi strategi utama dalam menjaga profesionalisme. Program pengembangan profesional berkelanjutan perlu disesuaikan dengan kebutuhan praktik dan perkembangan ilmu terkini.

## **2. Penguatan Sistem Penilaian dan Evaluasi Profesionalisme**

Selain pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan profesionalisme tenaga kesehatan juga memerlukan sistem penilaian dan evaluasi yang objektif dan berkelanjutan. Penilaian profesionalisme tidak hanya berfokus pada capaian kinerja kuantitatif, tetapi juga mencakup aspek perilaku profesional, kepatuhan terhadap standar, dan kemampuan kerja sama tim.

Sistem evaluasi berbasis kompetensi dan praktik nyata di lapangan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan individu tenaga kesehatan. Hasil evaluasi ini selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pelatihan, promosi jabatan, serta pengembangan karier profesional. Dengan demikian, sistem penilaian tidak bersifat menghukum, melainkan mendukung pembelajaran dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

## **3. Penerapan Praktik Berbasis Bukti**

Penerapan praktik berbasis bukti dalam pengambilan keputusan klinis berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

## **4. Penguatan Etika dan Nilai Profesional**

Internalisasi nilai-nilai etika profesi melalui pembinaan, supervisi, dan keteladanan pimpinan sangat penting dalam membentuk sikap profesional tenaga kesehatan.

## **5. Pengembangan Kompetensi Non-Teknis**

Kompetensi non-teknis seperti komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, dan manajemen konflik merupakan bagian integral dari profesionalisme.

## **6. Dukungan Organisasi dan Lingkungan Kerja**

Organisasi pelayanan kesehatan memiliki peran sentral dalam membentuk dan memelihara profesionalisme tenaga kesehatan. Lingkungan kerja yang kondusif tidak hanya ditandai oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga oleh budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme, keselamatan pasien, dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Sistem penghargaan dan penilaian kinerja yang adil dan transparan dapat meningkatkan motivasi dan komitmen profesional tenaga kesehatan. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak mendukung, minim apresiasi, serta sarat tekanan dapat memicu stres kerja dan burnout yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan.

Oleh karena itu, manajemen fasilitas pelayanan kesehatan perlu mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, termasuk penyediaan dukungan psikososial, kesempatan pengembangan karier, serta keterlibatan tenaga kesehatan dalam proses pengambilan keputusan.

Lingkungan kerja yang kondusif, sistem penghargaan yang adil, serta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan berperan penting dalam menjaga profesionalisme.

#### **E. Peran Kepemimpinan dan Kebijakan dalam Penguatan Profesionalisme**

---

Kepemimpinan yang efektif merupakan salah satu determinan utama dalam penguatan profesionalisme tenaga kesehatan. Pemimpin di sektor kesehatan tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan administratif, tetapi juga sebagai teladan dalam penerapan nilai-nilai profesional dan etika. Kepemimpinan transformasional yang mendorong partisipasi, inovasi, dan pembelajaran organisasi terbukti mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme tenaga kesehatan.

Di tingkat kebijakan, pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan profesionalisme. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan penting dalam penguatan sistem kesehatan nasional, termasuk pengaturan pendidikan, distribusi, perlindungan, dan pengembangan tenaga kesehatan.

Sinergi antara kebijakan nasional, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan untuk memastikan bahwa penguatan profesionalisme tenaga kesehatan berjalan secara berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap mutu pelayanan kesehatan.

#### **F. Implikasi Profesionalisme Terhadap Mutu Dan Keselamatan Pasien**

---

Profesionalisme tenaga kesehatan memiliki implikasi langsung terhadap mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang profesional cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar praktik dan prosedur keselamatan pasien. Hal ini berkontribusi pada penurunan kejadian tidak diinginkan (*adverse events*) dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Selain itu, profesionalisme juga berperan dalam meningkatkan pengalaman pasien melalui komunikasi yang empatik, pelayanan yang berpusat pada pasien, serta pengambilan keputusan yang transparan. Dengan demikian, penguatan profesionalisme tidak hanya berdampak pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga pada kinerja sistem kesehatan secara keseluruhan.

Dalam konteks pelayanan kebidanan dan kesehatan ibu dan anak, profesionalisme bidan berperan penting dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Kepatuhan terhadap standar

asuhan kebidanan, kemampuan deteksi dini komplikasi, serta komunikasi yang efektif dengan ibu dan keluarga menjadi indikator utama profesionalisme yang berdampak langsung pada luaran kesehatan.

### **G. Studi Kasus Penguatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Di Indonesia**

---

Penguatan profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya pada layanan kesehatan ibu dan anak. Salah satu contoh adalah penerapan standar asuhan kebidanan berbasis kompetensi dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Dalam praktik kebidanan, bidan dituntut untuk tidak hanya menguasai keterampilan klinis, tetapi juga mampu melakukan komunikasi efektif, pencatatan dan pelaporan yang akurat, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Implementasi audit maternal dan perinatal (*maternal perinatal audit*) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme bidan berkontribusi terhadap penurunan keterlambatan deteksi komplikasi dan peningkatan rujukan tepat waktu.

Pengalaman di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa program *midwifery update* dan pelatihan berkelanjutan yang difasilitasi oleh organisasi profesi mampu meningkatkan kepercayaan diri, kompetensi, dan sikap profesional bidan dalam memberikan pelayanan. Hal ini memperkuat peran bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat.

### **H. Penguatan Profesionalisme Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Kunci**

---

Bidan memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan nasional, khususnya dalam mendukung pencapaian target kesehatan ibu dan anak. Profesionalisme bidan mencakup kompetensi klinis, kepatuhan terhadap kode etik profesi, serta kemampuan memberikan pelayanan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*).

Penguatan profesionalisme bidan perlu difokuskan pada beberapa aspek utama, antara lain peningkatan kompetensi klinis berbasis bukti, penguatan etika dan tanggung jawab profesional, serta pengembangan kompetensi non-teknis seperti komunikasi, empati, dan kepemimpinan klinis. Selain itu, dukungan regulasi dan organisasi profesi sangat penting untuk memastikan bidan mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan pengembangan karier yang adil.

Dalam era transformasi sistem kesehatan, bidan juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan, seperti pencatatan digital, edukasi kesehatan berbasis media digital, dan sistem rujukan terintegrasi. Kemampuan ini menjadi bagian dari profesionalisme modern yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan.



## **I. Kerangka Konseptual Penguatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan**

---

Secara konseptual, penguatan profesionalisme tenaga kesehatan dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kompetensi, etika profesi, lingkungan kerja, dan kebijakan pendukung. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Etika profesi menjadi landasan moral dalam praktik pelayanan. Lingkungan kerja yang kondusif mendukung penerapan profesionalisme, sedangkan kebijakan dan kepemimpinan menyediakan kerangka regulasi dan arah strategis.

Kerangka ini menegaskan bahwa profesionalisme tenaga kesehatan, termasuk bidan, tidak dapat dibangun secara parsial. Diperlukan pendekatan sistemik dan kolaboratif antara individu tenaga kesehatan, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan pemerintah agar penguatan profesionalisme berdampak nyata terhadap mutu pelayanan kesehatan.

## **J. Tantangan Dan Peluang Profesionalisme Tenaga Kesehatan Di Masa Depan**

---

Ke depan, profesionalisme tenaga kesehatan akan semakin diuji oleh tantangan global seperti digitalisasi layanan kesehatan, perubahan pola penyakit, dan meningkatnya tuntutan efisiensi sistem kesehatan. Tenaga kesehatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi baru, termasuk pemanfaatan sistem informasi kesehatan dan telehealth, tanpa mengabaikan aspek humanistik pelayanan.

Di sisi lain, transformasi sistem kesehatan juga membuka peluang besar bagi penguatan profesionalisme. Dukungan kebijakan nasional, perkembangan teknologi pembelajaran, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan dapat menjadi pendorong peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan. Dengan kesiapan sumber daya manusia kesehatan yang profesional, sistem kesehatan nasional diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan secara lebih tangguh dan berkelanjutan.

## **K. Profesionalisme Tenaga Kesehatan Dalam Perspektif Interprofesional Dan Kolaborasi Layanan**

---

Pelayanan kesehatan modern menuntut pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai profesi kesehatan dalam satu sistem pelayanan yang terintegrasi. Profesionalisme tenaga kesehatan tidak lagi dapat dipahami secara individual, melainkan harus diwujudkan dalam konteks kerja tim interprofesional yang efektif. Kolaborasi antarprofesi, seperti antara dokter, bidan, perawat, tenaga

gizi, dan tenaga kesehatan lainnya, menjadi kunci dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Profesionalisme dalam praktik interprofesional ditunjukkan melalui kemampuan saling menghargai peran dan kewenangan masing-masing profesi, komunikasi yang terbuka dan efektif, serta pengambilan keputusan bersama yang berorientasi pada kepentingan pasien. Kurangnya pemahaman terhadap peran profesi lain dapat menimbulkan konflik, fragmentasi layanan, dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dalam konteks pelayanan kebidanan, kolaborasi interprofesional sangat penting terutama pada penanganan kasus komplikasi maternal dan neonatal. Bidan yang profesional tidak hanya mampu memberikan asuhan kebidanan sesuai kewenangannya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara tepat dengan dokter dan tenaga kesehatan lain melalui sistem rujukan yang efektif dan komunikasi klinis yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme bidan juga tercermin dari kemampuan bekerja dalam tim lintas profesi.

Penguatan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendekatan interprofesional perlu didukung sejak tahap pendidikan. Pendidikan interprofesional (*interprofessional education*) dapat menjadi strategi untuk menanamkan nilai kolaborasi, komunikasi, dan kerja tim sejak dini. Dengan demikian, lulusan tenaga kesehatan tidak hanya kompeten secara individual, tetapi juga siap bekerja secara kolaboratif dalam sistem pelayanan kesehatan.

Pendekatan interprofesional ini sejalan dengan upaya penguatan sistem kesehatan nasional yang menekankan pelayanan kesehatan terintegrasi dan berorientasi pada pasien. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan di masa depan perlu secara eksplisit memasukkan aspek kolaborasi interprofesional sebagai bagian integral dari kompetensi profesional.

## **L. Simpulan**

---

Profesionalisme tenaga kesehatan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan di era modern. Berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari perkembangan teknologi, tekanan kerja, hingga meningkatnya ekspektasi masyarakat, menuntut strategi penguatan profesionalisme yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penguatan profesionalisme tenaga kesehatan perlu dilaksanakan secara sistemik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penerapan praktik berbasis bukti, pengembangan kompetensi non-teknis, serta dukungan organisasi dan kepemimpinan yang efektif. Kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2025–2029, menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia kesehatan merupakan prioritas strategis untuk menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2025).

Dengan sinergi antara kebijakan, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, penguatan profesionalisme tenaga kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja sistem kesehatan nasional serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## M. Referensi

---

- Cruess, R. L., Cruess, S. R., & Steinert, Y. (2019). *Teaching medical professionalism: Supporting the development of a professional identity*. Cambridge University Press.
- Cruess, R. L., Cruess, S. R., & Steinert, Y. (2019). *Teaching medical professionalism: Supporting the development of a professional identity*. Cambridge University Press.
- Cruess, R. L., Cruess, S. R., & Steinert, Y. (2019). *Teaching medical professionalism: Supporting the development of a professional identity*. Cambridge University Press.
- Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., & Zurayk, H. (2010). Health professionals for a new century: *Transforming education to strengthen health systems in an interdependent world*. *The Lancet*, 376(9756), 1923–1958.
- Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., & Zurayk, H. (2010). Health professionals for a new century: *Transforming education to strengthen health systems in an interdependent world*. *The Lancet*, 376(9756), 1923–1958.
- Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., & Zurayk, H. (2010). Health professionals for a new century: *Transforming education to strengthen health systems in an interdependent world*. *The Lancet*, 376(9756), 1923–1958.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029. Kemenkes RI.

World Health Organization. (2016). *Global strategy on human resources for health: Workforce 2030*. WHO.

World Health Organization. (2016). *Global strategy on human resources for health: Workforce 2030*. WHO.

World Health Organization. (2020). *State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership*. WHO.

World Health Organization. (2020). *State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership*. WHO.

World Health Organization. (2020). *State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership*. WHO.

## N. Glosarium

---

**Audit maternal dan perinatal (maternal perinatal audit):** Proses penelaahan sistematis kasus kematian/komplikasi ibu dan bayi untuk menemukan penyebab serta perbaikan layanan agar tidak terulang.

**Distribusi tenaga kesehatan:** Pemerataan penempatan tenaga kesehatan antar wilayah; ketimpangan distribusi dapat meningkatkan beban kerja dan menurunkan mutu.

**e-learning:** Pembelajaran berbasis platform digital/online yang memungkinkan tenaga kesehatan belajar jarak jauh.

**Informed consent:** Persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien setelah mendapat penjelasan cukup tentang diagnosis, prosedur, risiko, manfaat, dan alternatif.

**Justice:** Prinsip etika tentang keadilan dalam pelayanan, termasuk pemerataan akses dan perlakuan yang setara sesuai kebutuhan pasien.





## PROFIL PENULIS



**Bd. Sri Wulan, S.ST, M.Tr.Keb**, Menyelesaikan pendidikan Program Diploma Tiga di Akademi Kebidanan Deli Husada Deli Tua. Penulis melanjutkan pendidikan Program Diploma IV Kebidanan di Universitas Sumatera Utara (USU), kemudian penulis melanjutkan pendidikan Magister Terapan Kebidanan (S2) di Poltekkes Negeri Semarang. Sejak tahun 2010 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen kebidanan dan saat ini penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Kebidanan Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta artikel pada jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email : [sriwulan@medistra.ac.id](mailto:sriwulan@medistra.ac.id).

Dengan terbitnya buku ini penulis sangat berharap agar buku ini dapat menjadi bahan acuan atau bahan proses belajar dan mengajar bagi mahasiswa dan Dosen Kebidanan, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas khususnya dalam ilmu kebidanan

***"Midwives Serve with Knowledge, Ethics, and Compassion"***



**Deasy Elvianita, S.ST., M.Keb**. Lahir di Kuala Tungkal, 05 agustus 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Kebidanan di STIKES Baiturrahim Jambi lulus tahun 2014 dan Diploma IV Bidan Pendidik, Fakultas Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIKES Guna Bangsa Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2020. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Surabaya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta kebidanan komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [Deasyelvianita1@gmail.com](mailto:Deasyelvianita1@gmail.com).

Motto: *"Happy Thought"*



## PROFIL PENULIS



**Dr. Nur Miladiyah Rahmah., S.Kp., M.Kep. Penulis** Lahir di Cirebon, 09 Februari 1980 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan dan Ners, Universitas Padjadjaran tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Fakultas Ilmu Keperawatan, peminatan Manajemen Keperawatan pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2013, dan melanjutkan pendidikan S3 keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus pada Tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004-2005 di Rumah sakit Hasan sadikin Bandung, dan pada tahun 2005-2008 di Universitas YPIB Majelangka, pada tahun 2009-2011, penulis bekerja di

City University Science dan Technology Malaysia. Saat ini penulis bekerja di Fakultas Kesehatan dan Farmasi, Universitas Bani Saleh sejak tahun 2013 dan mengampu mata kuliah Falsafah Dan Teori Keperawatan, Keperawatan Dasar, Keselamatan Pasien Dan Keselamatan Kesehatan Kerja, Penulisan Ilmiah, Manajemen Keperawatan, dan Sistem Informasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku manajemen keperawatan, sistem informasi kesehatan, berbagai publikasi hasil penelitian, dan juga sebagai reviewer di jurnal nasional dan internasional berhubungan dengan manajemen keperawatan dan sistem informasi teknologi kesehatan). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [nurmiladiyah@ubs.ac.id](mailto:nurmiladiyah@ubs.ac.id)



**Dra. Wiwin Winarti S.S., M.I.Kom.** Lahir di Bandung, 16 Februari 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, lulus tahun 1992. Jenjang S1 Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Inggris, Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dan lulus tahun pada tahun 2015. Penulis mulai mengajar di Politeknik Al Islam Bandung sejak tahun 2001. Mengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi, Komunikasi Terapeutik, Pengantar Strategi Negosiasi dan Inovasi Kewirausahaan.



## PROFIL PENULIS



**Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep.** Lahir di Padang, 19 April 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai dosen di Universitas Abdurrahman. Saat ini penulis bekerja di Universitas Hang Tuah Pekanbaru sejak tahun 2009 mengampu mata kuliah manajemen keperawatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Keterampilan Dasar Keperawatan, Biostatistik, dan Metodologi Penelitian.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, pembicara ilmiah pada seminar/ pelatihan nasional maupun internasional, reviewer jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta menghasilkan produk inovasi yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [siskamyg@htp.ac.id](mailto:siskamyg@htp.ac.id)



**Intan Rina Susilawati, S.ST., Bdn., M.Keb.** lahir di Garut pada 10 Mei 1976. Pendidikan tinggi ditempuh secara berjenjang di bidang kebidanan, dimulai dari pendidikan dasar kebidanan hingga menyelesaikan Program Magister Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran pada tahun 2018. Sebelumnya, penulis menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya serta pendidikan DIV Bidan Pendidik, yang memperkuat kompetensi akademik dan profesionalnya sebagai pendidik kebidanan.

Karier profesional penulis diawali sebagai bidan desa di wilayah Kabupaten Garut, kemudian berlanjut sebagai bidan praktik mandiri selama lebih dari satu dekade. Pengalaman praktik klinik tersebut memberikan landasan kuat dalam memahami pelayanan kebidanan secara komprehensif dan kontekstual. Sejak tahun 2011, penulis berkiprah di dunia pendidikan tinggi sebagai dosen kebidanan di STIKes Karsa Husada Garut. Saat ini, penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan STIKes Karsa Husada Garut serta aktif sebagai fasilitator Midwifery Update Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Garut.

Selain menjalankan tugas pendidikan dan pelayanan, penulis juga aktif dalam organisasi profesi, khususnya Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Garut, dengan berbagai peran strategis di bidang organisasi dan pendidikan. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen penulis dalam penguatan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia kebidanan.

Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik di alamat [rinasusilawatiintan2020@gmail.com](mailto:rinasusilawatiintan2020@gmail.com).



## **Sinopsis**

"Bunga Rampai: Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan di Era Modern" merupakan bookchapter yang menyajikan gagasan, konsep, dan pengalaman praktis terkait kebutuhan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan di tengah perubahan dunia kesehatan yang semakin cepat dan kompleks. Era modern ditandai oleh kemajuan teknologi dan informasi, meningkatnya tuntutan mutu layanan, kesadaran masyarakat terhadap hak pasien, serta berkembangnya isu etik–legal dalam praktik pelayanan. Situasi ini menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya unggul dalam keterampilan klinis, tetapi juga memiliki kompetensi profesional yang menyeluruh.

Melalui kumpulan tulisan dalam bunga rampai ini, pembaca diajak memahami berbagai aspek penting penguatan kompetensi, seperti komunikasi kesehatan yang efektif, pelayanan berpusat pada pasien dan keluarga, keselamatan pasien, kolaborasi interprofesional, sensitivitas sosial-budaya, literasi digital kesehatan, serta pemahaman etika dan hukum kesehatan. Bookchapter ini juga menyoroti tantangan nyata di lapangan—mulai dari keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, hingga kesenjangan komunikasi dan literasi kesehatan—serta menawarkan strategi penguatan yang aplikatif, termasuk pelatihan berkelanjutan, refleksi praktik, penggunaan media edukasi, dan pengembangan budaya kerja profesional.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa bidang kesehatan, tenaga kesehatan pemula, praktisi, pendidik, maupun pengambil kebijakan sebagai referensi untuk memperkuat kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan, bunga rampai ini diharapkan menjadi sumber belajar sekaligus bahan refleksi untuk membangun tenaga kesehatan yang kompeten, adaptif, beretika, dan mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, serta humanis di era modern.

“Bunga Rampai: Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan di Era Modern” merupakan bookchapter yang menyajikan gagasan, konsep, dan pengalaman praktis terkait kebutuhan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan di tengah perubahan dunia kesehatan yang semakin cepat dan kompleks. Era modern ditandai oleh kemajuan teknologi dan informasi, meningkatnya tuntutan mutu layanan, kesadaran masyarakat terhadap hak pasien, serta berkembangnya isu etik–legal dalam praktik pelayanan. Situasi ini menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya unggul dalam keterampilan klinis, tetapi juga memiliki kompetensi profesional yang menyeluruh.

Melalui kumpulan tulisan dalam bunga rampai ini, pembaca diajak memahami berbagai aspek penting penguatan kompetensi, seperti komunikasi kesehatan yang efektif, pelayanan berpusat pada pasien dan keluarga, keselamatan pasien, kolaborasi interprofesional, sensitivitas sosial-budaya, literasi digital kesehatan, serta pemahaman etika dan hukum kesehatan. Bookchapter ini juga menyoroti tantangan nyata di lapangan—mulai dari keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, hingga kesenjangan komunikasi dan literasi kesehatan—serta menawarkan strategi penguatan yang aplikatif, termasuk pelatihan berkelanjutan, refleksi praktik, penggunaan media edukasi, dan pengembangan budaya kerja profesional.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa bidang kesehatan, tenaga kesehatan pemula, praktisi, pendidik, maupun pengambil kebijakan sebagai referensi untuk memperkuat kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan, bunga rampai ini diharapkan menjadi sumber belajar sekaligus bahan refleksi untuk membangun tenaga kesehatan yang kompeten, adaptif, beretika, dan mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, serta humanis di era modern.

ISBN 978-634-7556-67-7



Penerbit:

**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

